四川大學

# 硕士学位论文

题目 小组工作提升精神障碍患者与家属沟通能力的干预研究

作者 刘娟秀 完成日期 2021 年 4 月 26 日

培养单位 四川大学公共管理学院

指导教师 崔珂 副教授

专业 社会工作

研究方向 家庭社会工作

授予学位日期 年 月 日

中国知网 https://www.cnki.net

# 小组工作提升精神障碍患者与家属沟通能力的干预研究

社会工作 专业

**研究生：**刘娟秀　　**教导教师：**崔珂

随着精神障碍患者人数的不断增加，我国精神疾病的负担将上升为全部疾病总负担的四分之一，在疾病总负担中居于首位。近年来，社会工作者开始以各种形式参与到精神障碍患者社区康复服务中，并已取得一定成效。本研究以池丽萍的亲子沟通理论、家庭系统理论和家庭抗逆力理论为指导，采用社会工作干预研究的研究范式，通过使用《家庭抗逆量表》和《亲子沟通量表》来评估精神障碍患者与家属间存在的沟通问题，并针对性地设计小组服务方案，以评估小组工作成效。

本文研究结果如下：提升精神障碍患者与家属沟通能力的小组工作具有一定效果。第一，小组工作增加了服务对象的沟通知识；第二，改变了服务对象的沟通认知；第三，增强了服务对象的沟通主动性；第四，转变了服务对象的沟通态度；最后，在小组服务过程中也提高了精神障碍患者的自信，增加了精神障碍患者家庭的社会支持。

但是本研究也存在一定的不足，笔者对不足部分进行以下反思。第一，虽然小组活动内容丰富，但针对性有待加强；第二，个人层面的服务难以推动整个家庭沟通系统的变化，小组活动应聚焦于家庭系统；第三，运用整合社会工作服务方法，提升服务效果；第四，引入广义教育学思想，提升服务对象的反思能力。第五，提升社会工作者的实务能力，保障服务对象参与度。

最后，本文也从家庭、专业社会工作机构和政府层面，提出了提升精神障碍患者及家属沟通能力的建议。首先，家庭需要建立良好的家庭氛围并加大同其他精神疾病家庭交流频率；其次，专业社会工作机构应当接受培训，开展长



中国知网 https://www.cnki.net

期、稳定、持续的服务，定期评估成效；最后，政府需要加大对精神障碍患者家庭的基本生活补贴与医疗保障，同时加大社会服务购买力度，为精神障碍患者提供更精准的社会服务。

**关键词：**小组工作；精神障碍；沟通能力；干预研究；社区康复；



中国知网 https://www.cnki.net

# Intervention Research of Group Work on Improving the Communication Ability of Patients with Mental Disorders and Their Family Members

**Major:** Social Work

**M.A.Candidate**: Liu Juanxiu **Superviser**: Cui Ke

With the increasing number of mental disorder patients, the burden of mental diseases in China will rise to one fourth of the total burden of all diseases. In recent years, social workers have participated in community rehabilitation services for mental disorders in many ways. Guided by the theory of parent-child communication, family system theory, and family resilience theory, this study adopts the social work intervention research paradigm and uses the "Family Resilience Scale" and the "Parent-Child Communication Scale" to evaluate the communication problems between patients of mental disorders and their family members. The group service plan is designed according to the above questions to evaluate the effectiveness of the group work.

This study draws the following conclusions: Group work is effective in improving the communication skills of patients of mental disorders and their families. Firstly, it increases the communication knowledge of the group members; Secondly, it changes the communication cognition of the group members; Thirdly, it increases the communication initiative of the members; Fourthly, it changes the communication attitude of the group members; And finally, it also improves the confidence of the mental disorders and increases the social support of the families of mental disorders through the group service.



中国知网 https://www.cnki.net

However, this study also has some limitations. Firstly, although the content of group activities is rich, the pertinence of the content needs to be strengthened; Secondly, it is difficult to promote the whole family communication system at individual level, and group activities should focus on the family system; Thirdly, integrated social work service method should be adopted to enhance service effect; Fourthly, in order to improve their communication ability, group members' reflective ability should also be intervened.

Finally, this study puts forward suggestions to improve the communication ability between patients of mental disorders and their families from the aspects of family, professional social work institutions and government. First of all, families should provide an open and inclusive family atmosphere for patients with mental disorders and actively use relevant social resources. Secondly, professional social work institutions should receive training, carry out long-term, stable and continuous services, and regularly evaluate service effectiveness. Finally, the government needs to increase the basic living subsidies and medical security for families of patients with mental disorders, and increase the purchase of social services to provide more targeted social services for patients with mental disorders.

**Key words:** group work, mental disorders, communication skills, intervention studies, community-based rehabilitation.



中国知网 https://www.cnki.net

# 目 录

1 绪论.....1
1.1 研究背景.....1
1.2 研究意义.....2
1.2.1 理论意义.....2
1.2.2 实践意义.....2
1.3 概念界定.....2
1.3.1 精神障碍.....2
1.3.2 沟通能力.....3
1.3.3 精神障碍社区康复.....4
1.3.4 干预研究.....4
1.4 理论基础.....5
1.4.1 亲子沟通理论.....5
1.4.2 家庭系统理论.....6
1.4.3 家庭抗逆力理论.....7
2 文献综述.....8
2.1 精神障碍患者社区康复研究现状.....8
2.1.1 国外研究现状.....8
2.1.2 国内研究现状.....10
2.2 亲子沟通能力研究现状.....13
2.2.1 亲子沟通能力研究现状.....13
2.2.2 社会工作提升亲子沟通能力的研究现状.....14
2.3 文献述评.....15
3 研究设计.....16
3.1 干预设计.....16
3.1.1 明确具体问题,开发项目理论.....16
3.1.2 创建并修订干预手册.....16
3.1.3 实施并评估干预成效.....17
3.1.4 总结研究结果.....17
3.2 研究方法.....17
3.2.1 资料收集方法.....17
3.2.2 资料分析方法.....18
3.3 伦理原则.....18
3.3.1 知情同意.....18
3.3.2 保密原则.....19

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.3 接纳原则.....19
4 前期预估.....20
4.1 评估工具.....20
4.2 精神障碍患者与家属沟通能力基本情况.....21
4.2.1 精神障碍患者与家属基本信息.....21
4.2.2 精神障碍患者与家属沟通能力情况.....23
4.3 沟通障碍问题表现.....24
4.3.1 表达主动性差,表达内容观点不清.....24
4.3.2 表达策略性不强,缺乏表达技巧.....25
4.3.3 倾听开放性差,无法形成双向沟通.....26
4.4 沟通障碍成因分析.....27
4.4.1 微观:孝道文化的影响及双方压力过大.....27
4.4.2 中观:家庭缺乏沟通氛围,相关能力支持不足.....28
4.4.3 宏观:社会对精神障碍患者的包容度有待提升.....29
4.5 提升精神障碍患者与家属沟通能力的必要性.....30
4.5.1 有利于减轻家属照顾压力.....30
4.5.2 有利于提升家庭抗逆力.....30
4.5.3 有利于精神障碍患者康复.....31
5 干预方案的设计与实施.....32
5.1 干预方案的设计.....32
5.1.1 项目理论.....32
5.1.2 服务计划.....34
5.2 干预方案的实施.....36
5.2.1 小组初期——熟悉与澄清.....36
5.2.2 小组中期——干预与强化.....38
5.2.3 小组后期——总结与延伸.....46
6 成效评估.....48
6.1 小组过程评估.....48
6.1.1 半结构式访谈评估小组过程.....48
6.1.2 参与式观察评估小组过程.....51
6.2 干预结果评估.....53
6.2.1 半结构访谈结果分析.....53
6.2.2 定量结果评估.....55
6.2.3 参与式观察评估小组成效.....56
7 反思与建议.....58
7.1 反思.....58
7.1.1 小组活动内容丰富,但针对性有待加强.....58
7.1.2 小组活动应聚焦于家庭系统.....58

中国知网 https://www.cnki.net

7.1.3 整合社会工作服务方法,提高服务效果 .....58
7.1.4 引入广义教育学思想,提升服务对象的反思能力 .....59
7.1.5 提升社会工作者实务能力,保障服务对象参与度 .....60
7.2 提升精神障碍患者与家属沟通能力的建议 .....60
7.2.1 家庭层面.....61
7.2.2 专业社会工作机构层面.....61
7.2.3 政府层面.....62
8 研究结论.....63
参考文献.....64
附录.....69

中国知网 https://www.cnki.net

# 1 绪论

## 1.1 研究背景

相关调查显示,我国持证精神残疾人数有 800 多万人,约占 8502 万残疾人总数的 10%，且仍处于持续增长的状态。据测算，到 2020 年底，我国精神疾病负担将上升到全部疾病总负担的四分之一，居疾病总负担之首（高万红，2019），可见我国精神健康问题已经不容小觑。

面对精神健康问题日益突出这一严峻背景，西方发达国家首先开始探索“去机构化”运动与社区康复服务。20 世纪 60 年代，英国“去机构化”运动拉开序幕（乔若杨，2018）。他们认为长时间的住院治疗与康复，会造成精神障碍患者长期与社会隔绝，而“去机构化”运动不仅能够使精神障碍患者的人权得到充分尊重，还能提高精神障碍患者的社会适应能力，减轻其残疾程度（赵环，2009）。20 世纪 70 年代，国外各地区相继开展针对精神疾病的社区康复服务。这种康复服务指精神病患出院后能够积极参与社区治疗，并接受相关生活技能培训，来减轻因精神疾病引起的功能缺陷，实现其身体、心理、社会和职业等方面的康复（刘晓利，2019）。相关研究表明，社会工作在参与精神障碍患者社区康复服务中发挥了重要作用（薛莉莉，2017；焦佳凌，2019；高万红，2019）。

2020 年底，中国残联等部门联合印发《精神障碍社区康复服务工作规范》，该规范强调精神障碍社区康复机构、社会组织等，应为精神障碍患者提供服药训练、预防复发训练、社交能力训练、同伴支持及家庭支持服务。同时，规范还要求具备专业知识的医务社会工作者以及致力于精神障碍患者社区康复的专业社会工作专业机构，应以各种形式参与到精神障碍患者的康复工作中。

笔者暑期曾实习于成都市一家服务社区精神障碍患者的社会工作机构。该机构致力于通过跨专业、多部门的合作，运用社会工作的专业理念和方法，关注精神障碍患者及家庭照顾者“身、心、社”方面的全人健康，协助精神障碍患者复元，并积极推动社区教育及环境改善，为精神障碍者营造一个接纳、包容、温暖的社区氛围。实习期间，该机构相继开展了服务于精神障碍患者个人、家庭层面的实务工作。但是，笔者在前期观察时也发现精神障碍患者与家属间存在沟通障碍，因而导致精神障碍患者与家属双方不能相互理解，他们时常感到心力交瘁，并频繁前往机构寻求社会工作者的帮助。



中国知网 https://www.cnki.net

因此，本研究将从这一现实背景出发，基于亲子沟通理论、家庭系统理论及家庭抗逆力理论的指导，分析评估精神障碍患者及家属间沟通现状及存在的问题，并针对性地设计小组工作服务方案，以期改善精神障碍患者与家属间的沟通能力，进而促进精神障碍患者家庭功能与家庭抗逆力的提升，恢复精神障碍患者的社会功能，实现精神障碍患者的社区融入。

## 1.2 研究意义

### 1.2.1 理论意义

首先，从研究对象来看，以往关于沟通能力的研究大多关注未成年子女与其成年家长的双向沟通，如单亲家庭儿童、留守儿童等，而较少关注此类成年后仍与父母同住，靠父母抚养的中年精神障碍患者群体。因此，本研究扩展了沟通理论的适用对象，为其他中年精神障碍患者与家属沟通能力的研究提供一定理论借鉴。

其次，从研究内容来看，笔者通过梳理精神障碍患者社区康复服务相关文献后发现，在精神障碍患者群体中，社会工作专业参与精神障碍患者社区康复服务的研究主要集中于精神障碍患者基本生活技能训练与社区宣传，较少关注精神障碍患者家庭内与家属间的沟通障碍。本研究旨在提升中年精神障碍患者与其年迈父母间的沟通能力，为社会工作参与精神障碍患者社区康复的相关研究提供了新的方向与思考。

### 1.2.2 实践意义

本研究是针对精神障碍患者及家属的干预研究。一方面可以为精神障碍群体的实务介入提供新的方向，为创新社会工作参与精神健康服务提供实践经验；另一方面，本研究在一定程度上也为其他大龄成年精神障碍患者与家属间沟通能力提升的服务项目提供思考与借鉴。

## 1.3 概念界定

### 1.3.1 精神障碍

《中华人民共和国精神卫生法》（2018 年）对精神障碍定义是：因患者自身或外界的原因而引起患者知觉、情感、思维等心理活动的紊乱，并导致患者



中国知网 https://www.cnki.net

出现严重心理困扰和社会功能损害的现象。世界卫生组织（WHO）发布的《国际疾病分类》（ICD）中将精神障碍分为器质性精神障碍、精神分裂症、未特指的精神障碍等 11 个类别。

本研究所服务的精神障碍患者大多为精神分裂症患者，他们被诊断为一、二级精神残疾。但这些精神障碍患者目前精神状态稳定、居家康复、坚持服药，并持续参加机构内其他服务。此外，本研究中参与服务的精神障碍患者家属多为患者母亲。

### 1.3.2 沟通能力

沟通学、管理学、社会学等学科分别从各自的学科视角出发，在“沟通”方面的研究已经取得了丰硕的成果。由于沟通的对象不同，学者在“沟通能力”的定义上也存在略微差异。由于本研究主要考察精神障碍患者与家属间的沟通能力，因此，笔者主要介绍目前常用的两位学者对沟通能力的定义。

Olson 等人（2003）在《婚姻与家庭：亲密，多样性和优势》一书认为，沟通能力主要包含倾听技巧、表达技巧、自我表达、口语清晰性、沟通主题集中程度以及沟通是否尊重他人等六个维度，他还从这六个维度编制了《沟通能力量表》来考察亲子沟通中个体的沟通能力。

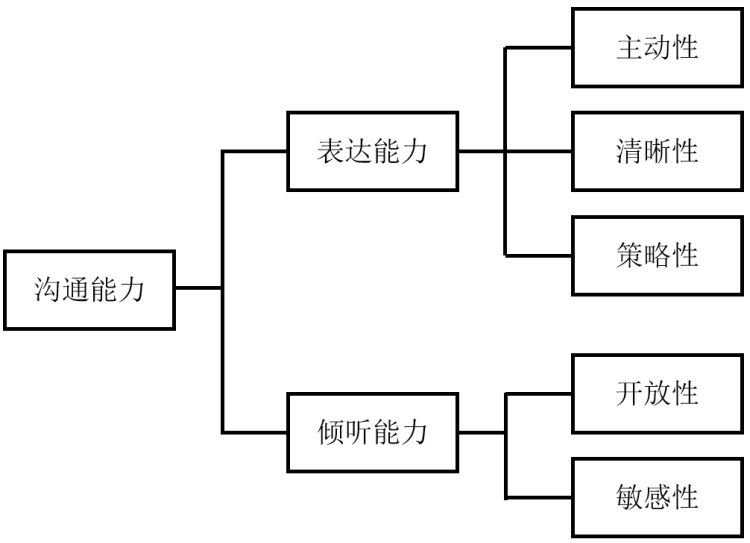
池丽萍（2011）认为表达能力和倾听能力是沟通能力的两个重要组成部分。同时，她将表达能力操作化为表达主动性、表达清晰性、表达策略性三个维度；将倾听能力操作化为倾听开放性和倾听敏感性两个维度，每个维度都包括 2-3 个条目（图 1）。其中，表达主动性指沟通者能够积极主动开始话题，积极发表观点；表达清晰性指沟通者能够清晰、有条理地提出自己的看法；表达策略性指沟通者能够有技巧地间接发表自己的看法；倾听开放性指沟通者能够接受与自己观点不同的看法；倾听敏感性指沟通者的应对能力，能毫不费力察觉对方感受。此外，她还将其编制成《亲子沟通量表》，并运用于学生群体，结果显示该量表信效度良好（池丽萍，2011；池丽萍，2013）。

由于池丽萍教授对于沟通能力的定义在国内普遍认可并被学者广泛引用，本研究沿用池丽萍教授对于沟通能力的定义。



中国知网 https://www.cnki.net

图 1 池丽萍亲子沟通理论模型图




### 1.3.3 精神障碍社区康复

康复的英文是“rehabilitation”，该词有通过培训或治疗使人“重新获得能力”、“恢复健康或正常生活状态”之意。

童敏（2006）对以往文献进行梳理后，从技能训练、同伴支持、职业康复和社区资源发展四个方面来界定精神障碍社区康复服务。

高万红（2019）认为，社区康复是以实现社区残疾人的个体成长为指导思想，以社区发展为依托，以促进社区残疾人的身心和社会功能康复为目标。它依托社区和康复人员及其家属，实现多部门、多组织的结合，并协助社区及家属整合相关资源，完善社区康复者的支持网络，缓解社区残疾人疾病程度，实现他们在社区和社会生活的成长与发展。

精神障碍患者社区康复离不开所在家庭的支持与帮助，本研究旨在提升精神障碍患者与家属间的沟通能力，即通过实施提升沟通能力的教育性小组工作，增进精神障碍患者及其家属对沟通的认知，促进家庭形成良好的沟通氛围，这也是精神障碍患者社区康复服务的重要内容。

### 1.3.4 干预研究

干预研究在中国的应用，最早来源于心理学领域及健康卫生领域，它强调



中国知网 https://www.cnki.net

通过降低风险因子，提升保护因子，来达到干预效果，检验干预成效（安秋玲，2018）。国内关于精神障碍患者的干预研究，最早可以追溯到 1992 年亢明等学者对精神分裂症患者进行社会心理实验，验证家庭治疗的干预效果，但该研究是心理学上的实验干预，并非社会工作干预研究。

社会工作干预研究作为一种科学的研究方法，近 30 年来在西方国家取得了积极有效的发展，但其在中国社会工作领域的发展目前仍处于起步阶段（孙晓冬、郭申阳、陈奇，2020）。迄今为止，我国社会工作领域能够找到使用干预研究的最早文献是2004年顾东辉等学者发表的关于青少年吸毒问题的干预研究（顾东辉、童红梅等人，2004）。社会工作干预研究的广泛传播可以说是从华东师范大学安秋玲教授 2018 年翻译的《干预研究：如何开发社会项目》一书开始的。

国内学者文军（2015）认为社会工作的干预研究，不应只是一个理论或研究的问题，而是在实务层面的操作与行动的问题，它需要通过某种策略和措施实施改变。对于我国社会工作实务来说，干预研究可以让我们知道要做什么改变，做了什么改变，哪些保障目标的实现，哪些阻碍目标的实现，它可以更客观地评估项目的整体情况。孙晓冬等人在总结布莱尔和弗雷泽几位学者对于社会干预研究的定义后，将社会工作干预研究定义为在社会工作领域从事的，为改变特定状况并达到预期目标，进而采取的干预、评估和证据传播的方法。它强调在开展、研究和传播社会服务过程中，研究者能够运用更加科学的方法（定量研究、质性研究或二者结合的混合研究方法），让社会服务能够有证可循（孙晓冬、郭申阳、陈奇，2020）。

本文属于社会工作干预研究，即通过小组工作的方法来干预精神障碍患者与家属间的沟通能力，并评估小组工作成效，传播证据与方法。

## 1.4 理论基础

### 1.4.1 亲子沟通理论

国内外已开展大量有关亲子沟通的理论研究，这些研究丰富了亲子沟通理论成果。本文主要介绍两个被学者们广泛引用的理论：

其一是奥尔森（1982）等学者从家庭沟通作用与功能的角度表达了他们对亲子沟通模式的观点。他们认为，个体与个体间的关系构成了家庭系统，家庭成



中国知网 https://www.cnki.net

员相互交流信息的方式会对他们关系的内容和形式产生影响，并最终形成每个家庭独特的家庭功能。该理论模型包括亲密度和适应性两个基本维度，而沟通是一个重要的促进维度，家庭成员可以通过沟通来表达亲密感，并处理与适应性相关的问题。

其二是池丽萍的亲子沟通三层次模型理论（2011）。亲子沟通包括元素、关系和系统三个层面。从系统论的角度来看，池丽萍认为家庭是一个以父母和子女为元素组成的系统，各元素之间的互动形成了亲子沟通（即父子之间、母子之间）。此外，家庭中的各种关系（父子关系、母子关系）也会相互影响，导致亲子疏离、亲子冲突等系统问题的产生。基于该理论的指导，池丽萍教授（2011）还编制了《亲子沟通量表》，该量表在亲子沟通关系层面，考察亲子沟通质量；在亲子沟通元素层面，聚焦家庭成员之间的沟通能力；在亲子沟通的系统层面，验证父子沟通和母子沟通的协调性与一致性。本文以此模型为理论支撑，重点关注亲子沟通的元素层面，即从精神障碍患者亲子沟通能力这个方面入手，评估精神障碍患者与家属间的沟通障碍，并设计小组服务方案进行干预。

### 1.4.2 家庭系统理论

家庭系统理论是社会工作实务研究中应用最广的理论之一。该理论认为，家庭内部错误的沟通方式是导致家庭产生问题的主要原因。因此，这些问题不应简单归结于个人原因或家庭成员的原因，更应该从在家庭系统内部来分析和解决（朱东武、朱眉华，2011）。

此外，要正确掌握“家庭系统”这个概念，就需要了解以下两个核心要素：第一，家庭不是各部分的简单相加，其整体产生的合力效果应大于部分之和；第二，家庭系统处于动态平衡的状态，每位成员的变化都会影响到其他家庭成员，它通过直接影响整个家庭系统并达到新的平衡，从而影响到其他家庭成员。

作为提升精神障碍患者与家属间沟通能力的研究，以家庭为单位来参与小组服务能够达到最佳的服务效果。但是，由于本研究的服务对象是中年精神障碍患者，其家属也多为老年人，因此，在实际开展服务的过程中遇到了精神障碍患者不愿出门，但其家属表示愿意参加；或者，因为家属年迈，出行不便，康复较好的精神障碍患者单独参加服务的现象。依据家庭系统理论中对于家庭



中国知网 https://www.cnki.net

系统的理解，一名家庭成员的改变将影响到其他家庭成员，这一观点为本文小组工作的执行起到了指导与支撑作用。

### 1.4.3 家庭抗逆力理论

家庭抗逆力理论的发展受个体抗逆力和其他理论，如家庭压力理论、系统理论、优势视角理论等的影响。许多学者认为家庭抗逆力是家庭风险因子和家庭保护因子的相互作用，于是他们从家庭风险因子和家庭保护因子两个方面分析。例如，Black（2008）认为家庭抗逆力主要包括积极态度、家庭沟通、家庭时光、支持网络等，这些元素均从保护因子的角度对家庭抗逆力框架进一步进行阐述。

此外，Walsh 教授基于长期临床实践，总结提炼出家庭信念系统、家庭组织模式、家庭沟通过程是家庭抗逆力的组成部分（朱眉华，2013）。其中，家庭信念系统是家庭看待逆境的观念、价值观与假设；家庭组织模式受到文化与家庭信念系统的影响，家庭必须能组织并利用他们的资源去缓冲压力，才能有效处理逆境中遇到的问题；家庭沟通过程更加至关重要，它能够促进家庭中各项功能的发挥。其中，清晰、坦诚的情感表达、沟通与问题解决能力是家庭沟通过程的重要因素。家庭抗逆力关键过程架构是建立在家庭潜力的基础上，即认为家庭之间的合作与支持能够使家庭走出困境，这是一种优势的视角。

家庭沟通过程是家庭抗逆力的重要组成部分，本研究是提升精神障碍患者与家属间的沟通能力，家庭沟通也是精神障碍患者家庭抗逆力形成与发展的过程。这不仅有益于为精神障碍患者营造家庭氛围，提升家庭功能，也能够促进精神障碍患者的身心康复，提升其社会功能。



中国知网 https://www.cnki.net

# 2 文献综述

## 2.1 精神障碍患者社区康复研究现状

精神障碍患者与家属间沟通能力的研究旨在为精神障碍患者提供家庭与社会功能康复，而社会功能康复是精神障碍患者社区康复服务的重要组成部分（高万红，2019）。因此，本研究从社会工作视角的精神障碍患者社区康复服务出发，以“社会工作+精神障碍患者+社区康复”及相对应的英文“social work +mental disorders +community-based rehabilitation”为关键词检索相关文献，梳理国内外学者对于精神障碍患者社区康复理论和实务的研究现状与特点。

### 2.1.1 国外研究现状

精神障碍患者社区康复服务的发展与成熟，是建立在 20 世纪中叶英国“去机构化”运动兴起的基础上的。但是，当时的研究主要集中于对“去机构化”作用与效果的研究，精神康复仅占据了非常有限的一部分。直至 20 世纪 70 年代，精神障碍社区康复的研究才开始取得了积极发展，并逐渐开始探索相关的理论模式与实务研究。

#### 2.1.1.1 理论研究现状

20 世纪末开始，由于学术界对精神障碍患者的研究开始从传统“问题视角”逐步向“优势视角”转型，复原的概念开始在美国精神康复领域内盛行。

精神健康领域在“复原”这一概念上暂未达成统一的观点，然而国外学者安东尼对“复原”一词的界定却被学者们广泛引用。他认为：复原是一个深刻而独特的过程，该过程包括案主的生活目标、态度、情感、角色和技能，在这一过程中案主能够体验到满意和有希望的人生历程。它是案主生命和人生意义的重整（刘芳，2019）。因此， 复原具备三大特质：一是精神障碍患者自身深刻而独特的体验；二是精神障碍患者生命历程的重整；三是这一过程深刻影响着精神障碍患者的人生意义与方向。

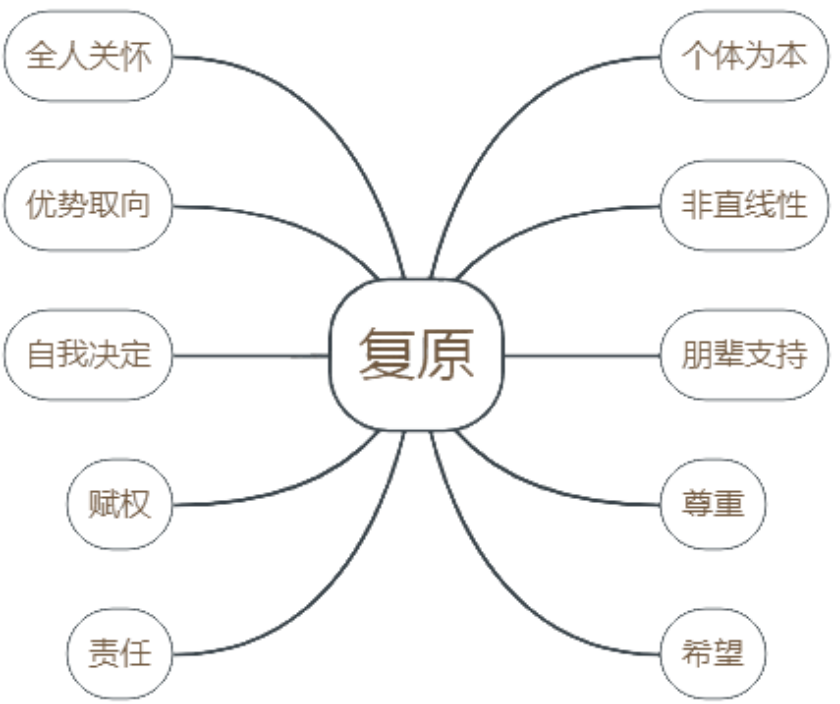
2004 年，美国详细阐述了精神障碍复原的十大原则（图 2），并将其确定为改革的目标。即要将精神障碍患者作为全人来对待，重视、尊重、接纳他们，为他们营造正常化的社区氛围。自 20 世纪末复原概念发展以来，该模式已在西



中国知网 https://www.cnki.net

方精神障碍患者社区康复中占据重要地位（高万红，2019）。

图 2 复原概念的 10 大原则




#### 2.1.1.2 实务研究现状

纵观国外精神障碍患者社区康复的文献研究，大多可以总结为以下两类：

一是精神障碍患者社区康复实践模式的研究，如主动式社区治疗模式（ACT）、认知行为模式（CBT）、证据为本模式（EBP）、个案管理（CM）、职业康复模式（VR）、社区为本（CBR）的康复模式以及会所模式（Club-house Model）等（高万红，2019）。

马歇尔（1998）等学者指出，主动式社区治疗模式的发展开始于 20 世纪 70 年代初，它是伴随着“去机构化”运动的需求而产生的。这一模式旨在协助社区内精神障碍患者获得治疗与相关精神康复服务，来降低入院率，提升其社会功能。与标准的社区照顾或医院康复相比，主动式社区治疗模式可显著降低精神障碍患者入院率，缩短其住院时间。



中国知网 https://www.cnki.net

认知行为模式近年来也广泛被用于辅助医学模式治疗精神分裂症。Bailey（2001）等人认为认知行为模式是一种问题取向的治疗模式，这种模式旨在发现和改变精神障碍患者的非理性信念。相关研究对精神障碍患者的认知行为治疗模式进行了总结，他们发现认知行为模式在实践过程中可以减少或稳定精神症状，这比抗抑郁药物更为有效（Hofmann .et al.，2012）。

此外，个案管理也是精神障碍社区康复的重要实务模式。个案管理的发展是为了回应“去机构化”运动后，精神障碍患者出院却面临不成熟的精神卫生系统这一问题的。Anthony（1988）等认为个案管理是指在各种服务活动中，案主可以根据自身的需要进行协商的过程。他结合以往研究提出个案管理为服务对象提供的四项基本活动：为案主链接资源、规划服务、将案主与服务连接起来、倡导服务的改进等，并以此来帮助社区内精神障碍患者提高社会功能水平，降低社会隔离。

二是各国开始探索医院——社区——康复中心这种多专业、多部门、一体化的实践。例如，法国精神卫生服务的主流模式“区域化的精神卫生服务模式”，即根据地理位置进行分区，由精神病院各科室结合中途宿舍、日间康复医院、家庭治疗中心等实现一体化精神卫生防治与康复体系（邹义壮，2000）；目前，澳大利亚精神康复的主要模式是医院——社区一体服务模式，即建立以全科医生为核心的全科医生——专科医生——其他专业人员分层管理模式，并应用于该国精神障碍患者社区康复实践中（李铁桥、马弘等，2007）。

### 2.1.2 国内研究现状

#### 2.1.2.1 理论研究现状

总体来说，我国学者在精神障碍社区康复理论研究较少，且仍处于探索阶段。香港学者叶锦成（2013）在整合精神分裂症相关理论的基础上，提出了“自我分裂和自我整合”的理论，并概括了社会工作干预精神分裂症的基本理论框架。该理论以人的整体性、人道性、关怀性、理解性和社会情境性为指导，要求工作者能够体会和理解精神分裂症患者的感受、经历和需要，了解精神分裂症的发病机制。

此外，不少学者也对精神障碍社区康复理论进行进一步发展。例如，黄曼聪等人（2009）对精神健康职能治疗进行详尽分析，并发展了精神健康职能治疗的



中国知网 https://www.cnki.net

理论与实务基础,这为社会工作参与精神障碍患者社区康复服务提供了重要的指导；高万红（2013）运用质性研究的方法,对 114 名患有抑郁症的青少年进行深度访谈,并从抑郁青少年的个体成长、人际关系和社会转型三个维度,提出了青少年抑郁症的多重失去的概念,丰富了有关青少年抑郁症的相关理论；童敏（2008）对精神障碍患者的生物-心理-社会模式的进行讨论,这对国内精神康复服务理论进行了重要的引进与诠释；花菊香（2010）分析了关于精神障碍患者社会支持的可行性策略,并试图从现存的理念性支持层面向操作性支持层面过渡,最终实现两者的整合。

#### 2.1.2.2 实务研究现状

笔者根据童敏（2006）对精神障碍患者社区康复概念的界定，从技能训练、同辈支持、职业康复和社区资源发展四个维度来梳理社会工作参与精神障碍社区康复的实务研究。

1.技能训练

社区康复中技能训练是指通过相关技能的培训,使精神障碍患者能够主动管理自己病症，常见的技能训练包括日常服药训练、生活技能训练、人际交往技能训练等（童敏，2006）。

一些研究者通过对精神障碍患者提供技能训练,证明了技能训练能够提升精神障碍患者的社会功能。例如，何雪松、余潇（2015）两位学者针对社区内 15 名康复期精神障碍患者开展包括情绪管理、人际社交、日常生活技能训练在内的若干个小组服务，结果显示长达半年的小组工作显著提升了社区精神分裂症康复患者的社会功能；学者俞银华、王丽娟（2014）等在社区开展精神障碍患者团队生活训练，该服务明显提高了精神障碍患者的人际交往能力和日常生活能力；何丽英（2018）等以精神分裂症患者为研究对象，探讨 5 周的团队生活技能训练改善该类患者的社会角色方面的效果，结果显示干预患者的社会功能缺陷筛选表总分显著低于对照组；宫焕凤（2014）有力的证明了社会交往技能的训练能够对精神障碍患者的康复起到有效的作用。

此外，由于精神障碍患者长期遭受社会歧视与污名，他们羞耻感强，自我效能感低，一些学者研究了技能训练对提升精神障碍患者自我效能感的有效性。例如，雷志洁、陈小红（2016）通过对研究组的精神障碍患者连续 12 周进行搭



中国知网 https://www.cnki.net

乘训练干预后，研究组的自我效能评分显著高于对照组。他们发现，通过社会技能训练，不仅能够提升精神障碍患者的自我效能感，还在一定程度上促进精神疾病的缓解（马依莎，2020）。

2.同伴支持

同伴支持是指精神障碍患者同辈群体间社会支持网络建设与发展（童敏，2006）。同伴支持旨在帮助精神障碍患者在日常生活中建立与普通居民一样的身份认同, 形成支持性的社区环境，同时通过同辈群体间相互帮助与鼓励，使精神障碍患者从原本被动的患者角色转变成积极的提供者角色, 并为社区中其他精神障碍患者的康复提供借鉴。

国内关于同伴支持的实务研究仍在探索阶段。刘晓雨（2019）采用互助成长型小组的方式为社区内精神障碍患者组建同伴小组，研究表明同伴小组改善了轻度精神障碍患者的自我认知；严芳、姚丰菊（2019）等学者在为社区内精神分裂症患者开展同伴支持的干预服务时发现，同伴支持可以改善社区精神分裂症患者的临床症状，改变精神分裂症患者对治疗原有的抵制情绪，促进社区精神障碍患者社会功能的恢复。

3.职业康复

职业康复是实现精神障碍患者康复非常重要的一个方面，即通过帮助精神障碍患者提高职业技能和职业适应能力的各种训练和支持活动，使精神障碍患者能够顺利参与工作，并在工作中发现自我价值（童敏，2006）。

职业康复是精神障碍患者融入社会的关键一步，但其效果仍不明显。例如，黄丹琪、程明明等学者（2018）在分析了社区内精神障碍患者康复现状后，采用整合社会工作服务方法，通过资源链接、技能培训、社区教育等方法为精神障碍患者就业康复提供了理论与实务的参考；徐原（2014）运用行动研究的方法，分析了昆明市 X 会所职业康复服务存在的问题，并针对性地设计服务方案，探讨了社会工作参与精神障碍患者职业康复的可能性。

4.社区资源发展

社区资源发展涉及所有能够协助精神障碍患者成功适应社区日常生活的各



中国知网 https://www.cnki.net

种支持性的活动，例如家庭教育、社区临时照顾、社区支持等服务（童敏，2006）。

社区资源发展能够为精神障碍患者康复提供有利环境与外部支持。国内关于精神障碍社区发展暂处于起步阶段。其中，赵鹤宾、夏勉等学者（2019）接触干预法应用于减少社区居民对精神障碍患者的公众污名，此举在社区内也达到了宣传与教育的目的。高万红（2016）研究会所模式应用于精神障碍患者社区康复过程，发现会所模式能够保障精神障碍患者在社区实现“正常人”的过渡，增加了精神障碍患者的社区支持。

## 2.2 亲子沟通能力研究现状

### 2.2.1 亲子沟通能力研究现状

沟通能力的研究已经取得丰硕的成果，笔者在中国知网以“沟通能力”为主题词进行文献搜索，检索出的文献多为医学、教育学、管理学领域中所指的一般人际沟通，如医患沟通、师生沟通、企业员工沟通等。此外，也有不少心理学、社会学、社会工作方向文献研究父母与子女间的沟通行为即“亲子沟通”。于是，笔者以“亲子沟通能力”为主题词进行文献检索，并将亲子沟通能力的研究现状及特点总结为以下几个方面：

一是调查分析不同家庭或个体亲子沟通能力的具体表现。其中，张干群（2013）调查了某省会学校 188 名高年级小学生家长的沟通能力，发现所有调查对象的亲子沟通能力均良好，他们能够敏锐地察觉孩子的情绪，也具备一定的沟通技巧和策略；褚安敏（2015）的调查发现不同年级的学生呈现显著差异，其中五、六年级学生的亲子沟通能力在表达能力维度高于三、四年级和七、八年级学生，而倾听开放性维度仅六年级学生显著高于其他年级。池丽萍（2012）比较分析了不同学业儿童的亲子沟通能力现状，发现成绩优秀儿童的表达主动性、清晰性和敏感性显著高于成绩较差儿童，成绩较低组父亲的表达清晰性和开放性显着低于优秀组父亲，李晓静（2014）将流动儿童亲子沟通能力总结为：父母与孩子的主观沟通意愿较高，但实际行动较低；父母在亲子沟通中的倾听能力较强，但家庭冲突的解决能力稍显不足。

二是分析亲子沟通能力的影响因素。大多文献均从父母因素、子女因素和家庭因素和文化因素四个维度分析亲子沟通能力的影响因素。其中，张干群（2013）调查发现父母受教育程度与其亲子沟通能力相关，父母受教育程度在本科及以



中国知网 https://www.cnki.net

上的家长亲子沟通能力越好；陈建伟（2020）从留守儿童的角度出发发现，除父母受教育程度外，留守儿童逆反心理、自我核心评价能力等也会影响亲子沟通能力。同时，相比正常家庭来说，离异家庭儿童表现出更多的亲子沟通问题（徐云、李幸 、余小敏，2013）。

此外，一些学者也分析了良好的亲子沟通能力的积极作用。他们发现亲子沟通能力可以显著预测流动儿童及大学生群体的幸福感，亲子沟通能力越强的个体，其主观幸福感也越强（陈丽、刘艳，2012）。另外，也有学者研究发现亲子沟通能力与学业成绩、社会适应等呈现正向相关（池丽萍，2012；方晓义、戴丽琼、房超，2006）。亲子沟通能力越强，其学业成绩越好，社会适应性越强。

### 2.2.2 社会工作提升亲子沟通能力的研究现状

社会工作是实务性学科，面对亲子过程中出现的沟通障碍，社会工作者做了大量的实务研究探讨提升亲子沟通能力的方法与手段，也取得了丰富的实务经验。

总体而言，社会工作提升亲子沟通能力的研究主要是运用小组工作的方法对服务对象家庭的亲子沟通能力进行干预，让亲子小组活动过程中，增加沟通互动，改善亲子关系(陈雪莹，2017；吴锐微，2017) 。这些小组活动内容丰富，例如，一些学者通过亲子绘本阅读的方式来改善亲子沟通现状（朱敏青、李颖茵，2020），也有学者运用亲子游戏的方式来提升亲子沟通技巧（赵加琴，2019），还有学者通过园艺治疗和绘画治疗的方法来缓解亲子沟通障碍（訾美玲，2018；胡毅，2018）；此外，社会工作提升亲子沟通能力的研究对象多样，包括隔代教养家庭儿童亲子沟通（张平，2020）、外来务工离异家庭亲子沟通（申佩佩，2020）、二孩家庭中一孩的亲子沟通（彭大丽，2020）、困境家庭的亲子沟通（陈慧萍，2019）等，这些研究均验证了小组工作在提升未成年人群体亲子沟通能力的有效性。但是，鲜有文献分析成年后仍与父母同住，靠父母抚养的中年精神障碍患者群体与其家属间的沟通现状及问题，并设计相关服务方案提高中年精神障碍与家属的沟通能力。



中国知网 https://www.cnki.net

## 2.3 文献述评

纵观上述精神障碍患者社区康复及沟通能力的研究现状，笔者认为现阶段的研究主要呈现以下特点：

首先，从研究方法来看，大量关于精神障碍患者社区康复服务及提升亲子沟通能力的实务研究均验证了小组工作的适用性与有效性。

其次，从社区康复发展现状来看，国外社会工作界参与社区康复服务已取得显著成效，而我国精神障碍患者社区康复仍以医学方向的研究为主导，社会工作的实务研究还有很大进步空间。从社区康复研究内容来看，目前国内社会工作参与精神障碍患者社区康复的内容在技能训练、朋辈支持、职业康复和社区资源发展均有涉及，其中以仍技能训练为主。一些学者开始探索人际沟通对于精神障碍患者社会功能提升的效果，但鲜有研究关注精神障碍患者与家属间沟通能力。

最后，从亲子沟通能力的研究现状来看，社会工作提升亲子沟通能力的干预研究在各类未成年人子女的研究中较为成熟，但对于本文中成年后仍与父母同住，靠父母抚养的中年精神障碍患者群体与其家属的沟通现状与沟通能力鲜有研究。

基于此，本文借鉴社会工作干预研究的范式，探索运用小组工作的方法对于提升精神障碍患者与家属间沟通能力的有效性。



中国知网 https://www.cnki.net

# 3 研究设计

## 3.1 干预设计

干预设计注重项目内容的开发（安秋玲，2018），是确定实践活动并安排实践顺序的创造性过程。它包括发现具体问题并分析研究文献，然后将其综合成实践策略，从而设计干预内容。依据安秋玲教授翻译的《干预研究：如何开发社会项目》一书中对于干预研究步骤的描述，本研究的干预设计主要有以下几个步骤。

### 3.1.1 明确具体问题，开发项目理论

干预研究首要步骤就是找出与实践相关的问题进行研究，并描述问题的发生率和流行度。在本研究中，笔者通过对机构内精神障碍患者与家属进行问卷调查及半结构式访谈，发现精神障碍患者及家属间存在沟通障碍，而沟通障碍会影响精神障碍患者及家属情绪、加重家属照顾负担、不利于精神障碍患者居家康复。基于亲子沟通理论，笔者发现精神障碍患者及家属间沟通障碍具体表现在：表达主动性差，表达内容观点不清；表达策略性不强，缺乏表达技巧；倾听开放性差，无法形成双向沟通。同时，笔者也从微观、中观、宏观层面分析了精神障碍患者与家属间沟通障碍的成因。

在明晰精神障碍患者与家属沟通障碍具体问题的基础上，笔者发展了提升精神障碍患者与家属沟通能力的项目理论，包括逻辑模型以及变化理论。其中，逻辑模型具体描述了提升精神障碍患者与家属沟通能力所需的目标、投入、活动、产出、中间结果和远端结果。变化理论描述了提升精神障碍患者沟通能力干预和改变的因果逻辑，为小组活动的实施提供依据。

### 3.1.2 创建并修订干预手册

干预手册主要包括干预的目标、设计的原则和结构、干预的具体内容等（安秋玲，2018）。

本研究是针对机构内部分沟通能力较低的精神障碍患者或家属，旨在通过教育性质的小组工作提升精神障碍患者与家属间沟通能力，以此提高精神障碍患者家庭抗逆力，促进精神障碍患者社会功能恢复。小组干预方案内容的设计



中国知网 https://www.cnki.net

是基于亲子沟通理论的指导，按照逻辑顺序，从表达能力与倾听能力两个维度设计，内容层层递进。同时，每一节小组内容也是基于内容的难易程度环环相扣，并通过安排家庭作业、应用练习和互动分享等方式提升服务对象参与积极性和内容有趣性。在干预手册设计过程中也考虑了频率与时间及小组实施场地的兼容性。

初步创建干预手册后，笔者将干预方案提交熟悉服务对象的项目负责人、督导及相关专家进行审查，进一步修订干预手册，以保障干预内容的可行性与有效性。

### 3.1.3 实施并评估干预成效

小组工作的实施过程中需要根据服务对象的反馈不断进行完善，确保干预活动的有效性。小组干预的效果主要通过问卷调查、半结构式访谈及参与式观察等方法来评估，具体包括过程评估和结果评估。其中过程评估是对整个干预的评估，包括分析小组活动内容、小组氛围及满意度、活动时间及地点安排等。结果评估主要分析小组工作提升精神障碍患者与家属沟通能力的小组工作的有效性，分析精神障碍患者及家属是否达到了预期目标。

### 3.1.4 总结研究结果

干预的目的是实现服务对象的“改变”，以研究为基础的干预材料也需要将其转化成实践。因此，干预研究的最后一步是总结此次干预的有效性与不足，并提出改进建议，为以后提升精神障碍患者与家属沟通能力及沟通能力的研究及实务工作提供实务参考。

## 3.2 研究方法

### 3.2.1 资料收集方法

#### 3.2.1.1 问卷调查法

问卷调查法是社会调查常用方法之一，即通过问卷的形式对收集数据资料，并对所收集到的资料进行统计分析（风笑天，2018）。本研究采用问卷调查的形式，使用自拟《基本信息问卷》、池丽萍编制的《亲子沟通量表》和李玉丽



中国知网 https://www.cnki.net

翻译修订的《家庭抗逆力量表》，来了解精神障碍患者与其家属间沟通能力现状，并根据实际调查结果，采取针对性的干预策略。

#### 3.2.1.2 半结构式访谈法

本研究采用半结构访谈的形式，首先在小组服务前，评估精神障碍患者与家属间沟通能力的现状与问题，并根据问题确定具体干预方案。其次，在小组结束后，采用半结构式访谈的形式，评估服务成效和服务满意度。

#### 3.2.1.3 参与式观察法

参与式观察法是小组过程评估时常用的方法。本研究中笔者既是研究者，也是小组活动带领者。基于双重身份，笔者能够深入观察小组内部互动情况，感受个体、家庭、小组间细节变化，从而对小组过程进行细致评估。

### 3.2.2 资料分析方法

首先，对于前期收集到的问卷数据资料，主要运用 SPSS25.0 统计软件进行描述性统计分析，了解精神障碍患者及家属间沟通能力的基本情况，并根据描述性分析结果进行半结构式访谈了解具体问题及原因。

其次，对于访谈收集到的定性资料，主要通过将访谈内容进行文字转录与整理的方法，并采用内容分析法，分析小组发展过程和团体动力，比较干预前后服务对象的发展与变化。

## 3.3 伦理原则

本次提升精神障碍患者与家属间沟通能力的小组工作，在方案设计以及具体内容的实施阶段的资料均已提交笔者实习机构督导进行审核，所有内容与资料均在机构督导的监督指导下完成，干预研究过程中遵循以下伦理原则：

### 3.3.1 知情同意

在问卷调查与半结构访谈过程中以及小组开始前，笔者已经向调查对象以及服务对象告知本次调查与服务的目的与意义、干预方法，让精神障碍患者及其家属理解干预内容，自愿参加本次小组服务。



中国知网 https://www.cnki.net

### 3.3.2 保密原则

本研究收集到的问卷调查以及半结构式访谈内容，在本文均已进行匿名处理，相关服务对象姓名使用阿拉伯数字的方式呈现。同时，研究过程中收集到的个人及家庭信息、活动参与情况仅笔者与机构督导知晓，并对内容进行严格保密。

### 3.3.3 接纳原则

一方面，对于精神障碍患者家庭来说，照顾一名精神障碍患者足以让一个普通家庭致贫，拖累身边一群人，这也使得精神障碍患者家属具有强烈的病耻感。但是，一些精神障碍患者也是通过社会工作机构服务作为窗口连接社会。因此，在小组中就必须做到接纳原则，接纳精神障碍患者及其家属。

另一方面，沟通障碍是每个普通家庭都会面对的问题，但这对于精神障碍患者家庭而言面对的沟通障碍更多。精神障碍患者家庭比普通家庭面对更多特殊的问题，他们很多人因为害怕排斥不愿意分享出来。这时社会工作者的接纳态度就至关重要。接纳服务对象不仅要做到接纳服务对象个人及家庭，同时也要接纳其背后的事件与问题。



中国知网 https://www.cnki.net

# 4 前期预估

## 4.1 评估工具

前期调研与评估主要采取定量研究与定性研究相结合的方法。首先，笔者邀请机构内正在参与其他服务的精神障碍患者及家属集中填写《家庭抗逆力量表》中家庭沟通与问题解决能力维度量表，初步了解精神障碍患者与家属间沟通与问题解决能力现状及问题。同时，根据家庭沟通与问题解决能力维度得分情况，邀请调查对象中总分低于 40 分，各条目平均值低于 2.5 分的成员进一步填写《亲子沟通量表》并进行半结构式访谈。按照自愿参与小组服务的原则，最终从 18 位调查对象中共计筛选出 7 位家庭沟通与问题解决水平较低的服务对象，参与小组服务。本研究在前期预估阶段使用的工具主要有以下三个：

1.自拟个人基本信息问卷。此问卷，依据机构内精神障碍患者家庭实际情况，采用自拟问卷的方式，调查服务对象姓名、性别、年龄、患病时长、家庭人口数、家庭经济状况等信息。

2.家庭抗逆力量表。《家庭抗逆力量表》是由学者李玉丽翻译修订，在国内最初用于父母肢体残疾的青少年家庭弹性的测量，且信效度结果显示良好（李玉丽，2016）。《家庭抗逆力量表》包括家庭沟通与问题解决能力、利用社会资源与持有积极看法三个维度。本研究选取《家庭抗逆力量表》中家庭沟通与问题这一维度分析精神障碍患者与家属间沟通能力。该维度共 16 个条目，所有条目均采用李克特 4 级评分法，评分标准为 1～4 分（1=非常不同意；2=不同意；3=基本同意；4=非常同意），总分范围为 16～64 分，分数越高表示精神障碍患者与家属间沟通能力越好。

3.亲子沟通量表。池丽萍教授（2011）编制的《亲子沟通量表》包括《亲子沟通能力分量表》、《亲子沟通质量分量表》和《亲子沟通系统分量表》。本研究使用《亲子沟通能力分量表》来测量精神障碍与家属间沟通能力。该量表共 20 条目，所有条目均采用李克特 4 级评分法，评分标准为 1～4 分（1=非常不符合；2=比较不符合；3=比较符合；4=非常符合），总分范围为 20～80 分，分数越高表示精神障碍患者与家属间沟通能力越好。



中国知网 https://www.cnki.net

## 4.2 精神障碍患者与家属沟通能力基本情况

本次问卷调查采用集中填写的方式，在集中填写的过程中，笔者根据调查对象的反馈对问卷中精神障碍患者及家属难以理解的条目进行逐条解释，以便精神障碍患者及家属能够读懂条目正确含义，这也保证了问卷的有效性。

### 4.2.1 精神障碍患者与家属基本信息

调查机构内精神障碍患者及家属的个人基本信息是本次调查问卷的第一部分。下表 2 为本次调查的 18 位精神障碍患者或精神障碍患者家属的个人基本信息。由下表 1 和表 2 可以看出：调查对象中有 12 人为精神障碍患者，6 人为精神障碍患者家属；本次调查男女比例基本均衡，精神障碍患者中有 5 名男性，7 名女性，精神障碍患者家属男女各 3 名；从患病时长来看，精神障碍患者均为长期患病，仅一位服务对象患病时间少于 10 年；并且其家庭人口数多为 2-3 人。同时，笔者也通过调查对象的经济情况来评估精神障碍患者及家属的社会阶层，结果显示精神障碍患者自评社会阶层集中于中下层或最下层，仅 1 名精神障碍患者认为自己处于中间层，这表示精神障碍患者家庭可能由于常年住院治疗与药物治疗，家庭经济情况较差。

表 1 调查对象中精神障碍患者个人基本信息（N=12）

| | 频次 | 有效百分比（%） |
|---|---|---|
| 性别 | | |
| 男 | 5 | 41.7 |
| 女 | 7 | 58.3 |
| 年龄 | | |
| 30 岁及以下 | 1 | 8.3 |
| 31~40 | 2 | 16.7 |
| 41~50 | 6 | 50.0 |
| 51~60 | 3 | 25.0 |
| 患病时长 | | |
| 10 年及以下 | 1 | 8.3 |
| 11~20 年 | 8 | 66.7 |



中国知网 https://www.cnki.net

| | | |
|---|---|---|
| 患病时长 | | |
| 21~30 年 | 2 | 16.7 |
| 30 年以上 | 1 | 8.3 |
| 家庭人口数 | | |
| 2 | 5 | 41.7 |
| 3 | 5 | 41.7 |
| 4 人及以上 | 2 | 16.7 |
| 社会阶层 | | |
| 最上层 | 0 | 0.0 |
| 中上层 | 0 | 0.0 |
| 中间层 | 1 | 8.3 |
| 中下层 | 6 | 50.0 |
| 最下层 | 5 | 41.7 |

表 2 调查对象中精神障碍患者家属基本信息（N=6）

| | 频次 | 有效百分比（%） |
|---|---|---|
| 性别 | | |
| 男 | 3 | 50.0 |
| 女 | 3 | 50.0 |
| 年龄 | | |
| 61~70 | 1 | 16.7 |
| 71~80 | 5 | 83.3 |
| 家庭人口数 | | |
| 2 | 1 | 16.7 |
| 3 | 5 | 83.3 |
| 4 人及以上 | 0 | 0.0 |
| 社会阶层 | | |
| 最上层 | 0 | 0.0 |
| 中上层 | 3 | 50.0 |
| 中间层 | 2 | 33.3 |



中国知网 https://www.cnki.net

| | | |
|---|---|---|
| 社会阶层 | | |
| 中下层 | 1 | 16.7 |
| 最下层 | 0 | 0.0 |

### 4.2.2 精神障碍患者与家属沟通能力情况

对机构内精神障碍患者及其家属的家庭沟通与问题解决情况的调查是本次问卷的第二部分。调查对象家庭沟通与问题解决能力分量表的测量结果显示，参与前期调查的18位精神障碍患者与家属家庭沟通与问题解决能力的得分相对较低，均值为 2.92。在各调查条目中，“我们能够一起讨论家庭遇到的问题，并能够达成让我们都满意的解决方案。”条目得分最低，均为2.31 分。这表明大部分精神障碍患者或家属很少能在一起讨论家庭中遇到的问题，或是即便是讨论过问题，但也不能达成统一的，令人满意的方案。在“我们愿意为解决家庭问题，付出时间和精力”这一条目得分最高，均分为 3.06。这也在一定程度上显示了部分精神障碍患者或家属有沟通的意愿，但在实际执行过程中效果不明显。

基于前期问卷调查结果，研究者选取家庭沟通与问题解决维度水平较差（问卷调查总分低于 40 分，各条目平均值低于 2.5 分）的 4 位精神障碍患者及 3 位家属，邀请他们填写《亲子沟通量表》，并进行一对一半结构式访谈。访谈内容围绕家庭沟通中面临的问题及产生原因展开。下表 4 是 7 位服务对象《亲子沟通量表》的调查情况：

**表 3 《亲子沟通量表》调查结果**

| 序号 | 表达能力 | | | 倾听能力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 主动性 | 清晰性 | 策略性 | 开放性 | 敏感性 |
| | 均值（标准差） | 均值（标准差） | 均值（标准差） | 均值（标准差） | 均值（标准差） |
| 1 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 2.50 | 2.75 |
| 2 | 2.00 | 2.75 | 2.75 | 2.00 | 2.25 |
| 3 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 3.50 |
| 4 | 2.00 | 2.50 | 1.75 | 3..25 | 2.75 |



中国知网 https://www.cnki.net

| 序号 | 表达能力 | | | 倾听能力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 主动性 | 清晰性 | 策略性 | 开放性 | 敏感性 |
| | 均值（标准差） | 均值（标准差） | 均值（标准差） | 均值（标准差） | 均值（标准差） |
| 5 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 2.25 | 3.00 |
| 6 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 2.75 |
| 7 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 |
| 合计 | 2.85（0.66） | 3.07（0.37） | 3.03（0.65） | 2.71（0.55） | 2.96（0.51） |

上表 3 展示了服务对象在表达能力和倾听能力两个维度与家庭成员间沟通情况，表达能力又细化为主动性、清晰性和策略性，倾听能力包括倾听开放性和敏感性。由上表 3 可以看出，调查对象在表达能力与倾听能力两个方面相对较差，各子维度仅有两项略高于 3 分，分别是表达清晰性和表达策略性。这表示服务对象认为自己能够较清晰地与家庭成员阐述自己的观点，面对棘手问题时也能够比较有策略的与家庭成员沟通。相反，在表达主动性与倾听开放性方面更低，均值分别为 2.85 和 2.71。这表示服务对象与家庭成员沟通时主动发起话题，参与谈话的倾向较弱；也不太能容忍和接受家庭成员与自己不同的看法。因此，在后续小组工作内容设计时，将会围绕亲子沟通量表各维度展开。

## 4.3 沟通障碍问题表现

笔者对 7 位服务对象进行半结构式访谈，将精神障碍患者与家庭成员间出现沟通障碍的表现，总结为以下 3 个方面：

### 4.3.1 表达主动性差，表达内容观点不清

一方面，家属认为子女患病后表达能力欠佳，与其沟通是一种浪费时间与精力的行为，双方沟通不能解决任何问题，于是精神障碍患者与家属间的沟通频率越来越少。同时，传统孝道文化在家属观念中根深蒂固，精神障碍患者家属认为晚辈必须要顺从长辈的观念与决定，因此家属与精神障碍患者间的沟通就变得不太重要；另一方面，精神障碍患者由于长期服药，他们语言表达能力变差，思维变缓，再加上其家属的不理解，这使得他们的家庭缺乏沟通氛围，



中国知网 https://www.cnki.net

他们即便在家也缺乏表达的空间，因此沟通意识逐渐减弱。

“我觉得没必要和她（精神障碍患者）沟通，反正给他们说了也不会记得。说那么多遍，我自己都烦的很。有时候吧看到她现在这个样子我也不想和她说话，我们就经常好几天都没话说，反正她天天就在自己的房间看电视，也不会主动和我说话。”（服务对象1）

“我不敢和我妈沟通，一直以来都是她说啥对就对，我就照着她说的做就是了，说多了她又要冒火了。”（服务对象2）

此外，表达清晰性不佳，表达内容观点不清也是精神障碍患者与家属沟通中常面临的问题。由于传统文化的影响，中国人普遍谈话比较委婉，往往不会直截了当表达观点。但是当运用此类沟通方式与精神障碍患者沟通时，大多数时候并不能实现有效沟通。

“我和我妈聊天都不知道她在说什么，每次说那么一堆话，都不知道重点在哪里，反正就是听不懂。要是我妈能和你这样跟我面对面坐下来一点一点的沟通，我可能理解的要多一点”（服务对象6）

### 4.3.2 表达策略性不强，缺乏表达技巧

精神障碍患者家庭出现沟通障碍的另一个表现形式是双方缺乏表达技巧，表达策略性不强：他们习惯把过错都纠结于对方，直言直语，不听任何解释与理由，缺乏与家人间正向沟通。精神障碍患者将自己患病原因归结于家人多方面施压；其家属又经常向社会工作者诉苦，表示自己的精神障碍子女做任何事都做不好，不让人省心。这不仅对自身情绪有极大影响，还破坏了双方的关系与情感。

“我就是说话太直接了，想说的话不能放在心里，必须得说出来。所以有时候，我虽然知道一些话会让女儿听了不高兴，会和我生气，但我看不惯、憋不住，就是要直接说出来。”（服务对象1）



中国知网 https://www.cnki.net

“我真的不知道怎么和我爸表达，就拿吃南瓜这件事来说嘛，我就是不喜欢吃。我也和他说过，他就是不听，还骂我逼着我吃，到现在还是顿顿都有。我也不想和他表达了，吃饭对我来说都没有什么意义。”（服务对象3）

“我女儿经常在路边捡垃圾还要带回家里放着，整个房间都脏兮兮的，我也不是说第一遍了，所以看到她捡垃圾回来我就要骂她，反正这样说几遍她也就晓得了。”（服务对象7）

### 4.3.3 倾听开放性差，无法形成双向沟通

亲子沟通量表测量结果显示，精神障碍患者及家属倾听水平较差。精神障碍患者及家属双方均缺乏倾听意识。家属受到传统家长作风的影响，他们认为倾听不重要，所有事情家属单方面决定就可以，无需浪费时间听其子女过多解释，这在沟通过程中也形成了父母单向支配的现象；此外，由于精神障碍患者思维迟缓、理解能力有限，他们不能完全理解父母话语中传达的意思，倾听开放性不强，无法给予家属相应反馈。因此，精神障碍患者与家属双方沟通过程中无法形成双向沟通。

“你看她（精神障碍患者）这个样子嘛，说了也懂不起。我喊她洗碗，她不晓得洗筷子；喊她帮我打扫房间，不晓得打扫客厅，我还是干脆自己来干还省心一点。”（服务对象4）

“她（精神障碍患者母亲）每天早上都要起来帮我做早饭，但是吧，你也知道，她因为我得了这个病啥事也不让我干。其实，我都和她说过了，我现在也康复的差不多了，想自己锻炼一下自己，但她连我用电磁炉都不放心，也不会听我说。”（服务对象3）

“我妈根本就不懂我，也不会听我解释，我早上吃了十多粒药真的吃不下早饭了，她还要天天让我吃早饭。”（服务对象6）



中国知网 https://www.cnki.net

## 4.4 沟通障碍成因分析

“人在环境中”的系统观把个体面临的问题与环境中的其他因素结合起来，它反对将问题单独归因于某一个体特质或其一外在因素，而应该从整个生态系统出发，来寻找解决问题的资源。下面，笔者将结合沟通障碍的文献分析并基于前期访谈资料与参与式观察分析精神障碍患者与家属间沟通障碍的原因。

### 4.4.1 微观：孝道文化的影响及双方压力过大

家长个性差异、子女性别及年龄差异都会影响亲子沟通及亲子关系（赵加琴，2019）。周波等学者（2007）认为，亲子沟通过程中母亲会给予更多建议，表达自己的想法与感受，这会降低亲子双方产生的沟通障碍；此外，不同性别的子女在与家长沟通中的表现存在差异，女孩在亲子沟通过程中表现的比男孩更为积极；同时，由于身心发展状况差异，不同年龄段的儿童在与父母沟通过程中表现出的沟通特点也不尽相同（汪光珩，2006）。

中国传统孝道文化在我国仍有相当的影响力。部分父母由于受自身成长环境以及传统观念的影响，他们对于亲子关系偏重于子女对父母的顺从，而忽略了其子女作为独立个体的主动性。这也形成了传统家庭中父母与子女的沟通不是平等的双向互动，而是单向支配的现象（赵加琴，2019）。此类现象在精神障碍患者群体中同样常见。精神障碍患者家属通常认为子女所有事情只要顺从父母即可。再加上他们的子女是精神障碍患者，自我意识不强，他们就更不用与精神障碍患者沟通，因为精神障碍患者也不太能听得懂，不能有效回应。

“和她说又说不听，第一次还是可以好好说，以后每次都这样你说我怎么能不冒火嘛。就像我喊她不要边吃药边喝茶，天天看到我都说，你问她听过我的话没有？我现在就不盯到她吃药了，不说她了，越说越心烦。”（服务对象4）

精神障碍患者与家属沟通障碍的另一原因是家属照护压力过大。访谈过程中精神障碍患者家属多次向社会工作者提及自己与家庭面临的困境，表达因无处倾诉的烦恼，导致与子女沟通过程中过于情绪化。

“你知道我上次帮她（精神障碍患者）去医院拿药，结果还在医院晕倒了嘛，天天忙着照顾她的日常生活，有时候我都没时间关注我自己的身体。所以



中国知网 https://www.cnki.net

每次想到这些事，我又说她啥时候能生活自理，越说就越生气。”（服务对象1）

同样，精神障碍患者也面临较大压力。他们接受了外界对于精神障碍患者诸多污名，同时由于身体上的诸多限制，他们在语言表达和理解方面的能力比其他人低很多，所以在面对家庭冲突时，他们常将问题归因于自己的精神疾病。由于他们对沟通的认知不足，精神障碍患者在面对冲突时，不敢直面问题，通常会选择逃避沟通冲突，这也加剧了他们负向情绪的累积，不利于精神障碍患者康复。

“我和家人经常说着说着就吵架，你说是不是因为现在我得这个病的原因啊，我怎么没听见别人家像我们家这样的情况。”（服务对象2）

“我以前没犯病的时候性格就内向，所有事情都藏在心里，不愿意和父母交流。我现在都这样了，尤其是吃了药以后，就更加不用沟通了。要是我没得这病，不吃这些药可能情况要好一点吧。”（服务对象6）

### 4.4.2 中观：家庭缺乏沟通氛围，相关能力支持不足

亲子沟通与家庭因素存在一定的联系。家庭结构、家庭氛围、家庭的社会经济地位以及家庭生活中秩序等都会对亲子沟通及亲子关系产生一定的影响（周皓，2013）。

由于参与本次小组的精神障碍患者家属均大于60岁，他们不仅要面对自己的身体健康问题，还面临巨大的照顾压力，这导致精神障碍患者家属身心疲惫，整个家庭缺乏沟通氛围。与此同时，精神障碍患者家庭还面临着家庭经济压力与负担，服务对象也曾向社会工作者表示，相关社会补助只能满足基本生计，因此在与精神障碍患者沟通时，小事杂事也会引起家庭矛盾，导致双方沟通障碍。

“我以前是当护士的，前几年都觉得自己工资还能支付她的药费，也没有帮她申请医保。我都是去年来你们这个机构了以后，你们的社工和我一起去跑那些手续，要不然我们家还不是要因为钱的问题产生矛盾。”（服务对象4）



中国知网 https://www.cnki.net

“你说我家里还有什么沟通的氛围，有一次半夜我女儿突然犯病半夜跑出去，我那时还在睡觉都不晓得，后来警察把她带回来的。后来，我担心她的情况，现在家里所有地方都装了防盗门窗，我天天心都是提起的，哪还有什么心情说其他。”（服务对象 7）

民政部等多部门联合印发《精神障碍社区康复服务工作规范》，要求“专业社会组织、社会工作机构等应为精神障碍患者提供服药训练、预防复发训练、社交能力训练、同伴支持及家庭支持服务”。社会工作机构作为精神障碍患者社区康复，融入社会，提升社会功能的重要力量，能够为精神障碍患者群体提供针对性的帮助，然而就目前而言，相关能力支持仍然不足。目前，专业机构针对精神障碍患者的服务内容主要仍集中于诸如服药训练、生活技能训练等基本康复训练，缺少系统的沟通训练支持，沟通能力缺少外在正向引导。对于精神障碍患者家属来说，相关喘息服务仍然无法满足实际需求。

“我觉得很有必要开这种培训，去年你们常来家里探望我和女儿，所以女儿的情况都开始慢慢好转说一点话了，愿意出去人少的地方走一走，和我说说话。现在因为今年这个疫情，又回到以前那个状态了。”（服务对象 1）

### 4.4.3 宏观：社会对精神障碍患者的包容度有待提升

公众污名是精神障碍患者面临的一个巨大挑战。赵鹤宾等学者（2019）认为公众污名使精神障碍患者遭受社会歧视，严重影响了精神障碍患者获得机会的可能。同时，部分精神障碍患者会将公众污名内化为自我污名，这也会降低精神障碍患者的自尊和自我效能感，影响其求助，治疗和康复。

现实生活中，由于少数精神障碍患者发病后具有暴力倾向等行为，加上社会公众对精神障碍患者认知不足，精神障碍患者家庭面临严重社会歧视，致使精神障碍患者更加自闭，不愿与家人沟通；同时，这种公众污名也加剧了精神障碍患者家属的自卑心理，部分家属也与精神障碍患者逐渐疏远。

“你看我现在恢复的还可以吧，我还试着出去找过工作。但别人一听说是



中国知网 https://www.cnki.net

精神残疾，就不要我了。他们那些听力残疾人那些还能找个服务员的工作，我们这些精神残疾的人，他们根本不会接受我们……有时候我回到家和我父母讨论找工作这件事，就会说着说着吵起来。”（服务对象3）

“我们也有残疾证嘛，出去做地铁都是免票，还可以携带一位免票的照护者。但每次我拿出我的残疾证，经常会受到别人异样的目光，我妈都不和我走同一个免票通道，因为不愿意让别人晓得。”（服务对象5）

“我读中专的时候犯病，还从2楼跳下来，现在都将近10年了。但我们家一直都瞒着周围的亲友邻居，没人知道我的情况，因为害怕别人讲闲话，也就是来机构参加你们的活动，我才告诉你们，所以我的家人除了每天监督我吃药以外，我们很少去讨论这个问题。”（服务对象5）

## 4.5 提升精神障碍患者与家属沟通能力的必要性

### 4.5.1 有利于减轻家属照顾压力

对于精神障碍患者家属来说，照顾患者是一项长期耗费精力与金钱的责任，这一责任已使家属面临巨大的照顾压力与经济压力。与此同时，家属在与精神障碍患者沟通过程还常常因为双方的沟通障碍，增加家属的负面情绪，当这些情绪得不到缓解与表达，也会加剧家属的照顾压力。相反，家属与精神障碍患者如若沟通顺畅，这能够为家庭带来轻松和谐的氛围，在一定程度上能够减轻家属照顾压力，促进家庭关系良性发展。因此，提升精神障碍患者与家属沟通能力，解决家庭成员间沟通障碍，有利于减轻家属照顾压力，这对于精神障碍患者家属非常有必要。

### 4.5.2 有利于提升家庭抗逆力

相关研究发现，即使在巨大的照护负担及压力下，一些家庭也能够通过动用家庭内外资源顺利度过逆境，促进家庭健康发展。这其中，家庭抗逆力作为逆境发生时的首要反应，起到了重要作用（朱眉华，2013）。家庭抗逆力在提升患者的康复效果、促进家庭的良好适应、减轻社会的疾病负担等方面扮演着重要角色。基于家庭抗逆力理论，家庭沟通与问题解决能力是家庭抗逆力的重要



中国知网 https://www.cnki.net

组成部分，患者与家属间的沟通障碍会影响着精神障碍患者家庭抗逆力。因此，提升精神障碍患者沟通能力有利于提高精神障碍患者家庭抗逆力。

### 4.5.3 有利于精神障碍患者康复

家庭是精神障碍患者回归社区、参与康复的首要环境，与家人间沟通是精神障碍患者人际沟通的第一步，它影响着精神障碍患者社区融入与社会功能的恢复。国内已有社会工作者参与到精神障碍社区康复的任务中，包括为精神障碍患者提供服药训练、生活技能训练等服务。提升精神障碍患者与家属的沟通能力亦是精神障碍患者社区康复的重要内容。因此，提升精神障碍患者与家属间的沟通能力有利于精神障碍患者康复。



中国知网 https://www.cnki.net

# 5 干预方案的设计与实施

## 5.1 干预方案的设计

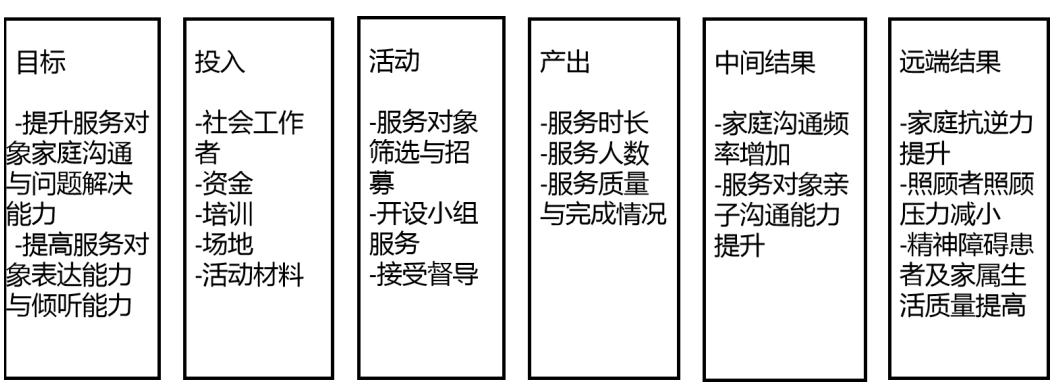
### 5.1.1 项目理论

项目理论能将干预方案如何设计，干预的因果逻辑这一“黑箱”公之于众（陶毛毛，2020）。所有的干预方案都有一种潜在的项目理论，项目理论就是干预方案可视化的表达。通常来说，项目理论确定了干预的目标、主要活动、改变或干预的执行者以及期望取得的成果。它描述了干预的因果逻辑，这一逻辑可以将某一干预措施将会如何起作用、为何起作用清晰呈现。两种常见的方法为逻辑模型和变化理论（安秋玲，2018）。

#### 5.1.1.1 逻辑模型

逻辑模型通常被用于阐明一个干预过程所需的目标、投入、活动、产出、中间结果和远端结果（安秋玲，2018）。本次小组工作的逻辑模型如下图 3 所示：

图 3 逻辑模型




其中，项目目标澄清了工作的焦点，本次小组工作主要目标即提升精神障碍患者与家属间沟通能力水平，主要包括提升服务对象家庭沟通与问题解决能力、提高服务对象表达能力和倾听能力。投入资源包括社会工作者、资金、场地、培训和活动材料等，以确保本次活动人力、财力、物力的专业性与有效性准备到位。活动产出则是按照前期调查结果和资源原则筛选符合条件的服务对



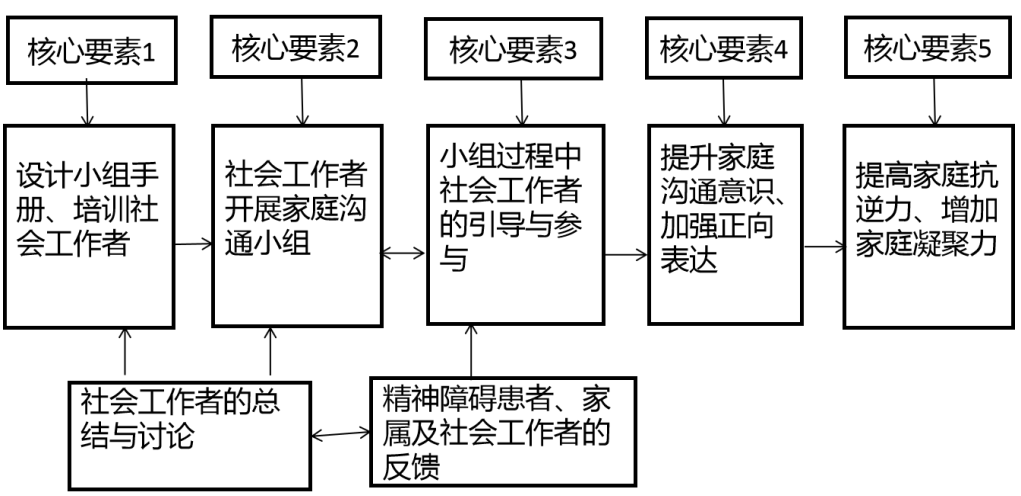
中国知网 https://www.cnki.net

象，开设提升精神障碍患者与家属沟通能力的小组工作，并产生实际影响。中间结果为家庭沟通频率增加，且服务对象亲子沟通能力提升；在社会工作者与服务对象的良性互动中，远端的结果则能够被预见，即提升了服务对象家庭抗逆力、减小了精神障碍患者家属照顾压力、提高了精神障碍患者及家属生活质量。

#### 5.1.1.2 变化理论

变化理论通常描述了选择某种特定干预方法的原因，为项目活动提供依据，并解释了干预的执行者及活动时间、活动地点等，即变化理论描述了获得预定结果的路径（安秋玲，2018）。本文提升精神障碍患者及家属沟通能力的变化理论过程，如下图 4 所示：

图 4 变化理论




上图显示，精神障碍患者与家属沟通能力的小组工作，主要包含了 5 个核心要素。核心要素 1 是此次小组工作的首要任务，即社会工作者设计小组活动方案并接受与之相关的培训，并熟悉干预过程的方方面面。在此次整个小组方案设计过程中，社会工作者不仅需要了解学习精神疾病和沟通理论的相关知识，还要对活动内容及开展有细致的认识。因此，在活动开展前，社会工作者全面了解精神疾病、沟通理论及小组工作相关知识后才能开展小组，并且还需接受



中国知网 https://www.cnki.net

实务督导。

核心要素 2 重点在于干预方案的实施方面，所以服务均需在小组方案的指导下执行，并开展相关服务。同时，小组活动过程中还需要营造积极温馨的氛围给服务对象以正向激励，进而提升精神障碍患者与家属间的沟通能力。此外，每一节活动开展后，所有的参与人员，包括主带社会工作者、志愿者以及督导都会本次小组过程中的优点与不足，讨论解决方案。同时，主带社会工作者也会对下节小组内容提前预告，提出自己的需要与问题，听取成员的建议，以期根据实际优化服务内容。

核心要素 3 与核心要素 2 是一种双向互动的关系，这种动态互动的过程非常重要。因为，每一节小组活动的开展都是社会工作者对服务对象在沟通能力方面的持续干预与引导，这样服务对象可以获得沟通技能，社会工作者再次开展小组，服务对象再次取得沟通技能的循环过程。

核心要素 4 中表示本次小组活动的近端结果，这代表小组取得的预期目标，即服务对象沟通能力的提升。他们不仅提升了沟通意识，还改变了原来负向沟通状态，增加了社会支持，从而解决了双方的沟通障碍，提高了自身表达能力与倾听能力，达到远端提升精神障碍患者与其家属间家庭抗逆力的提高以及家庭凝聚力的提高的远端结果。

### 5.1.2 服务计划

#### 5.1.1.1 小组类型

本研究设计开展的小组工作属于教育性质的小组工作。即通过帮助服务对象学习新知识、新方法、补充相关知识不足，促进其原有错误观点和解决办法的改变，以此来实现小组服务对象的发展目标。

#### 5.1.1.2 小组服务对象招募

在实际小组服务对象招募过程中，由于精神障碍群体自身的限制，部分精神障碍患者或因病情拒绝出门，只能家属参加。同时，部分家属年迈，只能康复者独自参加。因此，在小组招募时，主要集中于自愿参加家庭沟通小组工作的康复者或家属。



中国知网 https://www.cnki.net

#### 5.1.1.3 干预目标

本次小组工作总目标是提升精神障碍患者与家属间沟通能力，以此提高精神障碍患者家庭抗逆力，促进精神障碍患者社会功能恢复。具体干预目标包括以下几点：

1.透过小组内设计的游戏与互动，转变精神障碍患者与家属间的沟通态度，增加精神障碍患者家庭互动频率；

2.通过 8 节干预服务内容分享，增加精神障碍患者与家属对沟通能力的理论知识，强化服务对象对沟通重要性的正确认识；

3.通过社工引导、知识学习、经验分享等方式，改变精神障碍患者与家属间的沟通方式，增加服务对象表达主动性和倾听开放性；

#### 5.1.1.4 干预具体内容

本次小组工作共开展 8 节，可分为前期，中期，后期三个阶段。

小组前期即是第 1 节小组服务，该节小组内容主要包括组建小组并澄清小组目标，并让服务对象意识到良好家庭沟通环境对精神障碍患者康复的积极作用。

小组中期是此次干预的主题内容，共 5 节活动，其中第 2 节小组阶段目标是增加表达主动性，提升服务对象对双向沟通的认识；第 3、4 节小组主要干预服务对象表达清晰性。其中，第 3 节小组介绍负向沟通模式，让服务对象了解不良沟通模式对家庭双方造成的伤害。第 4 节小组则是通过重构正向的沟通方式，让服务对象了解正向沟通方式并能够在自己家庭中，在日常生活中能够不断实践，提升表达清晰性。第 5 节小组活动阶段目标干预服务对象表达策略性，本节小组是通过设计非语言沟通的内容，让服务对象了解到非语言沟通也是一种表达的策略。第 6 节小组服务主要干预服务对象倾听能力。每节小组内容的设计都围绕精神障碍患者与家属间产生的沟通障碍问题而设计，主题鲜明、内容丰富，从而促进活动目标的逐步实现。

小组后期主要是对整个小组工作的回忆与总结，巩固与提升以及对活动影响的延续。第 7 节小组设计家庭出行活动。因为笔者在前期访谈了解到，精神障碍患者家庭生活内容单一，活动场域范围小，共同出行不仅能够丰富生活内容，同样也是巩固家庭沟通的方式。第 8 节主题是回顾、评估与展望，该节小



中国知网 https://www.cnki.net

组邀请服务对象回顾每节小组内容，评估服务效果，展望未来。

表 4 小组活动一览表

| 节次 | 主题名称 | 小组目标 | 活动日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 初相识 | 1.服务对象间相互认识与了解<br>2.引导服务对象了解家庭沟通对精神障碍患者复原的重要性<br>3.初步了解服务对象家庭沟通状况 | 2020.8.18 |
| 2 | 双向沟通 | 1.提升服务对象家庭沟通意识<br>2.了解家庭中双向沟通的重要性<br>3.引导服务对象思考并分享家庭沟通面临的问题 | 2020.8.25 |
| 3 | 异化的沟通方式 | 1.引导服务对象了解日常沟通不畅的原因<br>2.协助服务对象梳理正确的沟通方式 | 2020.9.1 |
| 4 | 正向沟通 | 1.引导服务对象了解家庭沟通中的表达技巧<br>2.鼓励家属更多使用正向语言表达<br>3.鼓励家庭沟通中学会情绪控制 | 2020.9.8 |
| 5 | 非语言沟通 | 1.引导服务对象正向表达<br>2.帮助服务对象认识了解其他非语言表达方式 | 2020.9.15 |
| 6 | 倾听的力量 | 1.引导服务对象增加倾听意识<br>2.协助服务对象了解倾听的方式 | 2020.9.22 |
| 7 | 家庭出行 | 1.增加家庭共同活动频率<br>2.在日常生活实践沟通 | 2020.9.26 |
| 8 | 回顾与展望 | 1.复习巩固组内已学内容<br>2.评估小组服务成效 | 2020.9.29 |

## 5.2 干预方案的实施

### 5.2.1 小组初期——熟悉与澄清

#### 5.2.1.1 第一节小组

第一节小组可以用“熟悉”与“澄清”概括本节小组目标。本节小组主要目标



中国知网 https://www.cnki.net

就是社会工作者与服务对象以及服务对象之间相互认识，澄清本次小组目标，制定小组规范，并强调精神障碍患者家庭沟通重要性。

首先，在相互熟悉环节，除了常规的自我介绍，即了解服务对象姓名、年龄、所住社区等来寻找服务对象相似性外，社会工作者还设置了互动游戏来加强服务对象间的认识与交流。该游戏是将传统“击鼓传花”的基础游戏稍作改进，尽量降低活动的紧张感，营造温馨和睦的氛围。考虑到精神障碍患者及其老年家属对新形式游戏适应与接受程度较慢，因此选择传统游戏。

在相互认识、初步了解小组内容后，笔者向服务对象分享一则精神障碍患者克服各种困难成功就业的视频，剖析良好的家庭环境更加有利于精神障碍患者康复，融入社会，甚至能够达到就业的目标。而良好与顺畅的家庭沟通则是具备和睦家庭环境的前提。

**表 5 小组第 1 节计划书**

| 单元名称 | 初相识 | | |
|---|---|---|---|
| 活动时间 | 8 月 18 日 9:30-11:00 | 活动地点 | 社区种子博物馆 |
| 活动材料 | 投影、A4 纸、笔、满意度问卷、1 个玩偶 | | |
| 活动总体安排 | | | |
| 环节 | 阶段目标 | 方案 | |
| 暖场 | 1.营造轻松氛围<br>2.社会工作者与服务对象彼此熟悉 | 1.社会工作者引导服务对象签到<br>2.播放音乐暖场<br>3.社会工作者主动与服务对象交流提前到场的服务对象交流 | |
| 初期相识 | 1.服务对象间相互熟悉认识<br>2.活跃现场氛围<br>3.与服务对象建立初步关系 | 1.社会工作者与服务对象轮流做自我介绍<br>2.游戏击鼓传花规则介绍：准备玩偶，并播放音乐。音乐开始服务对象相互传递玩偶，音乐结束手中有玩具的人需要分享“本周内最开心的事情”。 | |
| 小组介绍 | 1.使服务对象清楚本次小组目的<br>2.了解服务对象对小组的期待 | 1.向服务对象介绍小组目的，并对后期活动做预告<br>2.邀请服务对象分享参加小组的期待 | |



中国知网 https://www.cnki.net

| 环节 | 阶段目标 | 方案 |
| --- | --- | --- |
| 小组规则 | 1.建立契约，培养秩序。<br>2.加强小组内部沟通与合作 | 1.告知小组规则的重要性<br>2.讨论、分享、制作小组规则 |
| 视频与分享 | 1.认识家庭沟通对精神障碍患者康复的重要性<br>2.引导服务对象分享与表达感受 | 1.社会工作者播放视频，服务对象观看视频<br>2.引导服务对象分享感受<br>3.引出话题，讨论家庭沟通对精神障碍患者复原的重要性 |
| 分享 | 强化主题，服务对象分享在本节中感受、收获 | 与服务对象一起回顾本节内容，社会工作者邀请服务对象分享本节小组印象最深刻的部分与收获 |
| 结束 | 1.分发家庭沟通任务卡<br>2.预告下节活动时间与地点 | 1.社会工作者布置本节小组作业——上周自己在家庭沟通中遇到的困难<br>2.填写满意度调查表<br>3.合影留念 |

### 5.2.2 小组中期——干预与强化

小组中期是整个干预活动的主题内容，包括第二至六小节。根据本次小组的干预目标，主要从提升服务对象表达能力与倾听能力。小组活动中主要通过体验式活动、视频分享以及主题讨论等形式调节服务对象对家庭沟通中表达与倾听的不合理认知。但是，由于服务对象精神障碍患者及其家属并未全部参加活动，且小组活动中无法展示家庭沟通日常状态，本小组无法在小组活动中进行实践。因此，本次小组主要通过家庭作业、自评与分享的形式让服务对象自我认识与调节。

#### 5.2.2.1 第二节小组

这一节是从小组前期过渡到小组中期的重要环节，主要目标是让服务对象了解到自身的情况，在服务对象之间的分享与交流中认识到家庭沟通并不是个别化的问题，在家属中都普遍存在，并且如果注意的话，可以有效改善。因此该节小组内容包括将本周内与家人的沟通情况进行分享，沟通障碍原因分析与总结两个部分。



中国知网 https://www.cnki.net

1.分别了解服务对象家庭沟通经验。此环节是笔者在上周设置家庭作业分享部分，让服务对象回忆与分享。

2.初步了解双向沟通，增加家庭沟表达主动性。首先，社会工作者通过“折纸游戏”的体验式活动带领服务对象感受在社会工作者模糊表达且服务对象不能提问的情况下，与服务对象可以自由表达情况下，根据社会工作者的指令折纸的差异。从而引出本节主题双向沟通。大多数情况下，在精神障碍患者家庭中往往呈现精神障碍患者家长不让精神障碍患者表达的情况。在这种情况下，一方面，精神障碍患者家庭需要主动表达、主动提问；另一方面，精神障碍患者家属也需要给予精神障碍患者足够的空间让其能够表达。

同时，社会工作者结合体验式游戏，通过向服务对象介绍双向沟通模型，分析家庭内沟通障碍的成因。在沟通过程中，信息会因为表达者或接收者对信息的理解偏差产生损耗，这时就需要双方的清晰表达与主动提问。

**表 6 小组第 2 节计划书**

| 单元名称 | 单向沟通与双向沟通 | | |
|---|---|---|---|
| 活动时间 | 8 月 25 日　14:00-16:00 | 活动地点 | 社区种子博物馆 |
| 活动材料 | 投影、A4 纸、笔、满意度问卷 | | |
| 活动总体安排 | | | |
| 环节 | 阶段目标 | 方案 | |
| 暖场 | 1.营造轻松氛围<br>2.与服务对象建立关系 | 1.社会工作者引导服务对象签到<br>2.播放音乐暖场<br>3.社会工作者主动与服务对象交流提前到场的服务对象交流 | |
| 回顾 | 巩固上节活动内容 | 社会工作者利用关键词引导服务对象回忆上节内容 | |
| 家庭作业分享 | 1.深入了解服务对象家庭沟通情况及面临问题<br>2.增强服务对象间沟通频率，加强服务对象间互动 | 1.社会工作者引导每位服务对象分享过去一周家庭沟通中面临的问题，起因、经过及解决方式<br>2.就个别服务对象事件从精神障碍患者及家属视角展开深度讨论 | |



中国知网 https://www.cnki.net

| 环节 | 阶段目标 | 方案 |
| --- | --- | --- |
| 折纸游戏 | 1.认识双向沟通<br>2.了解双向沟通重要性<br>3.介绍表达技巧 | 1.社会工作者向服务对象介绍折纸游戏规则，并开展两轮；一轮以小组为单位进行，另一轮两两分组进行<br>2.游戏结束后服务对象分享每一轮成功/失败的原因 |
| 双向沟通介绍 | 1.提升双向沟通意识<br>2.增加双向沟通知识 | 主带社会工作者介绍双向沟通图，了解家庭沟通矛盾成因及家庭中沟通必要元素 |
| 总结与分享 | 强化主题，服务对象分享在本节中感受、收获 | 与服务对象一起回顾本节内容，社会工作者邀请服务对象分享本节小组印象最深刻的部分与收获 |
| 结束 | 1.分发家庭沟通任务卡<br>2.预告下节活动时间与地点 | 1.社会工作者布置本节小组作业——上周自己在家庭沟通中遇到的困难<br>2.填写满意度调查表<br>3.合影留念 |

#### 5.2.2.2 第三节小组

第三、四节小组主要目标是改善服务对象对表达清晰性的不合理认知。其中，第三节小组主要通过异化的沟通方式，并将常见的几种进行总结，让服务对象认识到自己无意识的话语可能也对家庭内造成了伤害，从而使自己在生活中能够避免。具体内容主要包括：

1.负向沟通经历分享：社会工作者邀请服务对象分享家人对不经意间对自己的伤害，给自己造成的影响，至今还不能忘却的事情。以此让其他服务对象认识到，自己无意识说出的话对于别人可能造成了长时间的影响。

2.负向的沟通方式：笔者引用《非暴力沟通》中的 4 个类型总结。主要包括道德判断、进行比较、回避责任、强人所难（阮胤华，2009）。以上 4 种沟通方式，或多或少都会给家人造成伤害。因此，在家庭中更应该看到家人的长处和优点，于是，社会工作者采用“优点轰炸”的游戏，让服务对象分别写出自己的优点和其他服务对象的优点，并进行分享，以加强服务对象对自我以及其他服务对象的正向认知，增加表达的正向经验。



中国知网 https://www.cnki.net

**表 7 小组第 3 节计划书**

| 单元名称 | 异化的沟通方式 | | |
|---|---|---|---|
| 活动时间 | 9 月 1 日　14:00-15:30 | 活动地点 | 社区种子博物馆 |
| 活动材料 | 投影、A4 纸、笔、满意度问卷 | | |
| 活动总体安排 | | | |
| 环节 | 阶段目标 | 方案 | |
| 暖场 | 1.营造轻松氛围<br>2.与服务对象建立关系 | 1.社会工作者引导服务对象签到<br>2.播放音乐暖场<br>3.社会工作者主动与服务对象交流提前到场的服务对象交流 | |
| 回顾 | 巩固上节所学内容 | 社会工作者利用关键词引导服务对象回忆上节内容 | |
| 家庭作业分享 | 1.强化上节活动内容，增强双向沟通意识<br>2.帮助服务对象树立信心 | 1.引导服务对象留意双向沟通，并不断进行实践<br>2.就个别服务对象事件从精神障碍患者及家属视角展开深度讨论 | |
| 负向沟通方式的“力量” | 1.引导服务对象换位思考体会负向沟通的感受<br>2.了解负向沟通方式内容 | 1.服务对象分享家人曾经无意间的负向表达，对自己的影响与伤害<br>2.邀请服务对象回顾思考曾经自己无意间的言语是否对家人的伤害 | |
| 负向沟通方式 | 1.增加不良沟通方式的认知<br>2.引导服务对象与家人沟通时避免使用此类语言 | 社会工作者向服务对象介绍四种负向沟通方式：道德判断、进行比较、回避责任、强人所难 | |
| 优点轰炸游戏 | 从优势视角出发，引导看到自己和朋友的优点 | 社会工作者邀请服务对象在白纸正面写下自己的优点，反面写上其他服务对象的优点，并分享。 | |
| 总结与分享 | 强化主题，服务对象分享在本节中感受、收获 | 与服务对象一起回顾本节内容，社会工作者邀请服务对象分享本节小组印象最深刻的部分与收获 | |



中国知网 https://www.cnki.net

| 环节 | 阶段目标 | 方案 |
| --- | --- | --- |
| 结束 | 1.分发家庭沟通任务卡<br>2.预告下节活动时间与地点 | 1.社会工作者布置本节小组作业——和家人相处最愉快的时候<br>2.填写满意度调查表<br>3.合影留念 |

#### 5.2.2.3 第四节小组

第四节小组则是对第三节小组进行深入与补充，即回应在家庭内如何沟通才能使家庭成员不受到伤害。本节小组主要目标就是加强服务对象的正向沟通经验。

表 8 小组第 4 节计划书

| 单元名称 | 正向沟通 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 活动时间 | 9 月 8 日　14:00-16:00 | 活动地点 | 社区种子博物馆 |
| 活动材料 | 投影、A4 纸、笔、满意度问卷 | | |
| 活动总体安排 | | | |
| 环节 | 阶段目标 | 方案 | |
| 暖场 | 1.营造轻松氛围<br>2.与服务对象建立关系 | 1.社会工作者引导服务对象签到<br>2.播放音乐暖场<br>3.社会工作者主动与服务对象交流提前到场的服务对象交流 | |
| 回顾 | 巩固上节所学内容 | 社会工作者利用关键词引导服务对象回忆上节内容 | |
| 家庭作业分享 | 1.强化上节活动内容<br>2.引导服务对象关注聚焦家庭沟通内部优势 | 服务对象分享“与家人相处最愉快的时候”，与服务对象一起讨论思考愉快沟通的原因 | |
| 沟通技巧知多少 | 增加对正向沟通技巧的认知与实践<br>2.引导服务对象组内实践 | 社会工作者参考《非暴力沟通》内容，参考其中观察、感受、需要、请求四步骤，与生活实例结合，与服务对象一起讨论 | |



中国知网 https://www.cnki.net

| 环节 | 阶段目标 | 方案 |
| --- | --- | --- |
| 总结与分享 | 强化主题，服务对象分享在本节中感受、收获 | 与服务对象一起回顾本节内容，社会工作者邀请服务对象分享本节小组印象最深刻的部分与收获 |
| 结束 | 1.分发家庭沟通任务卡<br>2.预告下节活动时间与地点 | 1.社会工作者布置本节小组作业——尝试运用以上 4 个步骤与家人朋友沟通，并分享效果<br>2.填写满意度调查表<br>3.合影留念 |

#### 5.2.2.4 第五节小组

第五节小组主要目标就是提高沟通的策略性，此处表达策略性是指检查服务对象的表达技巧，间接达成目的的能力。因此，本节小组主要以“非语言沟通”为主题来达成沟通策略性。具体内容包括以下几个部分：

1.非语言沟通知多少

非语言沟通同样也是日常生活中与家人表达信息、分享心情的重要一环，但这在实际生活中却被不少人忽视。一个细微动作，一个不留意的眼神也同样传达着重要情感。因此，笔者在设计该部分内容时，首先应当让服务对象了解非语言沟通的主要形式。同时通过小组讨论的方式让服务对象能够意识到非语言沟通的重要性，特别是对于精神障碍患者在自己无法用语言表达想法自己的想法的情况下，可以使用非语言沟通。

2.制作感恩卡片

此外，本节小组内容更重要的一个环节是写感恩卡片，此活动的目的一方面是为了从优势视角出发，让精神障碍服务对象能够看到自己父母多年来的不容易与无私付出。同时，也是让精神障碍患者家属能够看到自己子女多年来饱受疾病的折磨，以及对子女在不断康复的肯定。

**表 9 小组第 5 节计划书**

| 单元名称 | 非语言沟通 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 活动时间 | 9 月 15　14:00-15:30 | 活动地点 | 社区种子博物馆 |
| 活动材料 | 投影、A4 纸、笔、满意度问卷 | | |



中国知网 https://www.cnki.net

| 活动总体安排 | | |
|---|---|---|
| 环节 | 阶段目标 | 方案 |
| 暖场 | 1.营造轻松氛围<br>2.与服务对象建立关系 | 1.社会工作者引导服务对象签到<br>2.播放音乐暖场<br>3.社会工作者主动与服务对象交流提前到场的服务对象交流 |
| 回顾 | 巩固上节所学内容 | 社会工作者利用关键词引导服务对象回忆上节内容 |
| 家庭作业分享 | 1.巩固强化上节活动内容<br>2.引导服务对象开放式分享表达 | 邀请服务对象分享沟通成效 |
| 非语言沟通内容 | 了解非语言沟通的内容 | 介绍非语言沟通行为与表情、高质量陪伴、身体的接触、赠送礼物等主要方式 |
| 制作感恩卡片 | 实践非语言沟通 | 邀请服务对象将口头极少表达过的话，利用卡片的方式写下送给家人 |
| 总结与分享 | 强化主题，服务对象分享在本节中感受、收获 | 与服务对象一起回顾本节内容，社会工作者邀请服务对象分享本节小组印象最深刻的部分与收获 |
| 结束 | 1.分发家庭沟通任务卡<br>2.预告下节活动时间与地点 | 1.社会工作者布置本节小组作业——将卡片送给家人，并分享感受家人的感受与自己的感受<br>1.填写满意度调查表<br>2.合影留念 |

#### 5.2.2.5 第六节小组

沟通是一个说与听必须兼顾的过程，需要双方的及时反馈与互动。笔者在前期调查中发现，精神障碍患者与家属沟通过程中双方都忽略了倾听。因此，第六节小组则以提升服务对象倾听能力为主。

□



中国知网 https://www.cnki.net

**表 10 小组第 6 节计划书**

| 单元名称 | 倾听的力量 | | |
|---|---|---|---|
| 活动时间 | 9 月 22 日 14:00-15:30 | 活动地点 | 社区种子博物馆 |
| 活动材料 | 投影、A4 纸、笔、满意度问卷 | | |
| 活动总体安排 | | | |
| 环节 | 阶段目标 | 方案 | |
| 暖场 | 1.营造轻松氛围<br>2.与服务对象建立关系 | 1.社会工作者引导服务对象签到<br>2.播放音乐暖场<br>3.社会工作者主动与服务对象交流提前到场的服务对象交流 | |
| 回顾 | 巩固上节所学内容 | 社会工作者利用关键词引导服务对象回忆上节内容 | |
| 家庭作业分享 | 1.引导服务对象开放式分享表达<br>2.巩固上节活动内容 | 邀请服务对象依次分享与讨论 | |
| 你比我猜 | 1.了解倾听的重要性，提升服务对象倾听意识<br>2.加强小组互动 | 1.社会工作者介绍你比我猜规则，邀请服务对象轮流上台比划<br>2.分享游戏过程中沟通与倾听的作用 | |
| 视频讨论分享 | 1.提升精神障碍患者家庭双方倾听意识<br>2.了解倾听在沟通中的重要性 | 1.社会工作者播放“超级演说家”相关视频<br>2.引导服务对象讨论分享自己的经历 | |
| 总结与分享 | 强化主题，服务对象分享在本节中感受、收获 | 与服务对象一起回顾本节内容，社会工作者邀请服务对象分享本节小组印象最深刻的部分与收获 | |
| 结束 | 1.分发家庭沟通任务卡<br>2.预告下节活动时间与地点 | 1.提前告知服务对象小组将结束，处理服务对象离别情绪<br>2.填写满意度调查表<br>3.合影留念 | |



中国知网 https://www.cnki.net

### 5.2.3 小组后期——总结与延伸

#### 5.2.3.1 第七节小组

第七节小组主要目标是社会工作者带领服务对象一起外出参观，了解大自然与社会环境，增加精神障碍患者及其家属的互动频率。

表 11 小组第 7 节计划书

| 单元名称 | 欢乐同行 | | |
|---|---|---|---|
| 活动时间 | 9 月 26 日 10:00-16:00 | 活动地点 | 熊猫基地 |
| 活动总体安排 | | | |
| 环节 | 阶段目标 | 方案 | |
| 集合 | 1.保证人数到齐<br>2.确保出行安全 | 提前招募志愿者随行 | |
| 出行 | 1.深入观察了解服务对象家庭沟通情况<br>2.增加家庭共同活动频率<br>3.在日常生活实践沟通 | 提前预订门票并了解免票措施 | |

#### 5.2.3.2 第八节小组

第八节小组活动的目标是回顾与总结前 7 次小组活动内容，巩固服务对象在小组过程中发生的改变，并将小组成效延伸至组外。在这一部分中，社工将利用投影仪，以照片和视频的形式，将 8 节小组活动串联起来。内容包括从小组初期服务对象相识到服务对象认知变化，再到行为的改变的过程。同时，整个视频也会对内容详细描述来引起服务对象的回忆，并用 ppt 播放的形式呈现小组中每个环节具体内容，使服务对象回忆每节小组的收获和改变，并展开自由讨论。在自由讨论过程中，服务对象可以分享如何将小组的内容运用到实际生活中，并在小组结束后继续学习，以提高服务效果。

最后一次小组活动正值中秋时节，因此本次小组工作以做冰皮月饼的形式向大家道别。同时，也为服务对象间提供一个亲密互动的机会，将之前所学的亲子沟通技巧运用到家庭互动过程中。



中国知网 https://www.cnki.net

**表 12 小组第 8 节计划书**

| 单元名称 | 回顾与展望 | | |
|---|---|---|---|
| 活动时间 | 9 月 30 日　14:00-16:00 | 活动地点 | 社区种子博物馆 |
| 活动材料 | 投影、A4 纸、笔、满意度问卷、家庭抗逆力沟通能力问卷、亲子沟通问卷 | | |
| 活动总体安排 | | | |
| 环节 | 阶段目标 | 方案 | |
| 开始与回顾 | 巩固小组内容 | 1.社会工作者放映活动视频<br>2.通过 PPT 回忆小组内容 | |
| 共制手工月饼 | 1.提高家庭活动频率<br>2.增强服务对象自信心与满足感 | 提前准备道具，与服务对象一起制作冰皮月饼 | |
| 一句话分享 | 巩固小组内容 | 社会工作者引导服务对象分享参与小组感受 | |
| 填写小组满意度调查表与后测问卷 | 小组成效评估 | 1.合影留念<br>2.填写后测问卷 | |
| 深度访谈 | 小组成效评估 | 依据访谈提纲进行访谈 | |
| 结束 | 处理服务对象离别情绪 | 1.填写满意度调查表<br>2.合影留念 | |



中国知网 https://www.cnki.net

# 6 成效评估

## 6.1 小组过程评估

### 6.1.1 半结构式访谈评估小组过程

#### 6.1.1.1 服务对象对小组内容满意度较高

小组内容与形式能否契合活动目的是决定能否产生成效的关键。通过半结构式访谈，服务对象对此次小组内容整体满意度较高。具体表现在：

“我非常喜欢这个小组，在小组里我能够充分表达自己的观点。”（服务对象3）

“这种让服务对象讨论的小组形式我非常喜欢，可以和同伴们交流非常多的经验。我也可以和我的家长多多交流。”（服务对象5）

“在小组里面和大家分享也锻炼了我的表达能力，这样的设计很好，我现在也在开始和我父母说一些自己的想法了。”（服务对象2）

第一，活动内容适用。本次小组在设计小组内容时，一方面增加了服务对象理论知识，让服务对象理解家庭矛盾、家庭沟通障碍的成因，同时引导服务对象换位思考，从不同立场与视角分析沟通问题。另一方面，理论知识能够与实际生活事件结合。小组中预留充分时间，让服务对象结合自身状况发表感受，相互探讨解决办法。此外，小组结束后，服务对象需要完成家庭沟通任务，这一形式的设计也及时巩固了干预效果。

第二，活动形式新颖。本次小组干预设计告别传统教与学的方式，将热身游戏、讨论分享、小组习作、电影赏析、理论方法与技巧短讲等形式结合，丰富了小组内容。服务对象能够畅所欲言，就某一个问题展开深刻讨论，互相提供意见从而解决问题。

#### 6.1.1.2 小组氛围良好，服务对象关系和睦

社会工作者在与服务对象访谈过程中，服务对象一致认为此次小组氛围非



中国知网 https://www.cnki.net

常好。首先，社会工作者在活动过程中真诚、不歧视精神疾病和精神障碍患者，并能够与服务对象建立良好关系。其次，服务对象间信任彼此，他们都能够真诚、坦率把自己面对的问题毫无保留分享出来，与大家共同探讨解决方法。整个小组氛围好，服务对象间关系和睦，这极大程度也促进了干预效果的产生。

“我在和这么多同学一起上课、玩游戏非常开心。我很喜欢和大家一起相处。”（服务对象 6）

“我在小组中感受到了，社工真的可以不带任何偏见的看我们，”（服务对象 3）

“我很喜欢我们这个小组的氛围，大家都能够把自己过去的发生的事情，还有一些想法和感受说出来，说明我们都把大家当自己人了。”（服务对象 5）

#### 6.1.1.3 小组活动的时间安排有待完善

本次小组工作从 2020 年 8 月 18 日开始开展第一节小组活动至 2020 年 9 月 30 日第八节小组活动结束，共计八节活动。下表为本次小组活动实施列表，分别展示每次小组活动的开展时间、时长等信息。

表 13 小组活动实施列表

| | 第 1 节 | 第 2 节 | 第 3 节 | 第 4 节 | 第 5 节 | 第 6 节 | 第 7 节 | 第 8 节 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活动日期 | 8.18 | 8.25 | 9.1 | 9.8 | 9.15 | 9.22 | 9.26 | 9.30 |
| 开始时间 | 9:30 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 小组时长 | 90min | 120min | 90min | 90min | 90min | 90min | 90min | 120min |

参与小组的服务对象中，有近一半是精神障碍患者，他们早晚都会吃大量抑制神经活跃的药物，如氯氮平等。因此，将活动设置在下午最为合适。在预备第一次小组活动时，机构内专职社会工作者建议笔者将活动时间设置在上午，以锻炼他们早起的能力。但第一次活动结束后，服务对象就向社会工作反馈，建议活动时间改在下午。于是在征得全体服务对象的一致同意后，本次小组又



中国知网 https://www.cnki.net

将活动时间调整至下午。

“早上我根本起不来，我平时都是 11 点多才起床，要参加你这个上午的小组我就要晚上 9 点就必须吃了药睡觉。我还得前一天提醒我弟好多次，让他一定要早上把我叫醒。”（服务对象 3）

“时间比较尴尬，我早上九点半参加活动，11 点才结束，我还得去买个菜，回家做饭，参加上午的活动，时间就比较紧，所以我还是建议改在下午。”（服务对象 4）

每节小组活动时长在 90 分钟左右，会根据活动内容及服务对象的分享情况稍作调整，确保每位服务对象在小组中有所收获。由于第二节小组活动时间过长，服务对象注意力不集中。因此，在经过第一、二次小组活动后，笔者发现，活动时长 90 分钟是服务对象最能接受的时间，此后服务时间都尽量控制在 90 分钟。

“我对后面几节活动时长比较满意，时间刚好，这样我能听的更加认真。”（服务对象 5）

由于干预对象是精神障碍患者，记忆力不高容易忘记小组活动内容。而在本次小组工作中，小组活动的频率通常是以一周开展一次，这使得小组干预活动的内容出现断裂，不再连贯，以下是服务对象对小组活动时间与频率的建议：

“我们每周差不多都忘了上节活动内容了，只有等到你提醒关键词才想得起来。我觉得咱们的课还可以每次复习时间增加一点或者像别人小组一样一周开两次。”（服务对象 5）

“我觉得小组选时间时，还应该再斟酌一下，开后面几节小组时每次都在下雨，我们这些家比较远的根本无法外出参加活动。”（服务对象 6）



中国知网 https://www.cnki.net

此外，在小组活动第四节后一位精神障碍患者家属中途退出。原因是社会工作者因为学校通知，所以频繁更改活动时间，导致该服务对象误解为社会工作者对本次小组不关注、不上心。社会工作者为服务对象详细解释后，服务对象表示理解，但因修改小组时间后，与服务对象每周时间安排冲突，无法参加后续小组。以下为服务对象 7 的访谈记录：

“你们这些学生平时又要上课又要来机构里面实习，时间改过来改过去，也给我们造成了不便。这个小组也可以让 C（志愿者）来带，我觉得她也挺好，你还是在学校好好学习。”（服务对象 7）

“你们实习生是非常需要实践锻炼的机会，但我在这个小组也投入了感情，你现在把时间换过来换过去，是不是根本没有用心在做这个小组？”（服务对象 7）

“我了解你这个情况了，但是我家里确实有些私事，每周这个时间段我都要去找律师，所以确实来不了。” （服务对象 7）

诚然，个别服务对象针对本次小组的干预频率、时间段及时长方面均给予了不少建议，在干预时间选择上午或下午这件事上也展现了笔者在机构内三重身份带来的矛盾。作为机构社会工作实习生，必须要服从机构社会工作者的安排，锻炼服务对象早起的能力；作为实务研究者，更应当最大程度为服务对象创造有利于参与小组服务的时间；作为在校学生，当预期干预时间与学校通知冲突时，又如何选择。这些都是在实务过程中不可忽略的。

### 6.1.2 参与式观察评估小组过程

#### 6.1.2.1 服务对象参与度有待提高

本次小组依据前期干预方案，从 2020 年 8 与 18 日至 2020 年 9 月 30 日每周开展一节小组，共 8 节。所有服务对象均未能全部参加。这种现象产生的原因是多样的。笔者将其总结为三个方面。第一，服务对象的特殊性。参与此次小组的服务对象均是精神障碍患者或其老年家属。老年人身体状况不好，存在



中国知网 https://www.cnki.net

因为身体情况而退出小组的现象。第二，服务时间的不稳定性。一方面，由于各方面的因素，本次小组未能统一时间，多次修改活动日期。因此，在还未与服务对象充分建立关系时，部分服务对象因不满时间变动而中途退出。另一方面，时间设置也不合理。小组开展前，社会工作者并未充分调研。最初活动时间定在早上，但由于精神障碍患者服药嗜睡，部分服务对象睡过头而缺席，因此在第二节小组时便将时间更改至下午。第三，服务对象项目可选择性多。成都市内越来越多社区关注弱势群体，并开展各式各样的服务，来丰富他们的生活，例如职业培训、健身课程等。同时，这些项目以丰厚的金钱奖励来吸引服务对象参加。由于本次服务对象均无固定收入来源，因此更倾向于参加此类提供报酬的活动，导致一些服务对象无法完整参加本项目。

#### 6.1.2.2 社会工作者角色不断变化

笔者在本次小组工作中扮演着双重角色，首先应是实务工作者，其次是研究者。作为实务工作者，自己的角色也不是一成不变的，而是随着小组过程的深入和变化而转变的。

小组初期社会工作者的角色主要是服务提供者、领导者与协调者。首先，社会工作者是向服务对象提供服务的人，初次见面需要社会工作者在组内带领服务对象了解小组目标、规则等内容。其次，社会工作者需要在组内协调服务对象间关系，避免小团体的产生，并且鼓励成员大胆互动、表露、倾听。

小组中期是冲突产生与小组成熟的阶段，本次小组中社会工作者也遇到此类情况。有服务对象私下向社会工作者反应，在沟通过程中，因一位服务对象反复质疑另一位服务对象表达事件的真实性，甚至怀疑该精神障碍患者是否疾病复发而产生误解、发生争执。社会工作者发挥协调者的角色，并在一次小组结束后，单独向双方澄清问题，解决问题。

小组后期服务对象呈现对离组不舍情绪。他们表示希望社会工作者能建立小组微信群，继续保持线上联络。社会工作者及时向服务对象澄清不建群的原因，并及时处理服务对象离组情绪。



中国知网 https://www.cnki.net

## 6.2 干预结果评估

### 6.2.1 半结构访谈结果分析

第八节小组结束后，社会工作者邀请服务对象进行团体访谈，发表各种感受等等。笔者将访谈资料整理形成评估总结：

#### 6.2.1.1 沟通知识的增加

通过此次小组内容的学习，服务对象增加了许多沟通理论相关知识，如双向沟通，负向沟通，正向沟通等知识，例如在第一次小组活动的讨论中，服务对象开始意识到与家庭成员间的沟通障碍是个普遍性的议题，但同时也存在具有个别化的差异；第三、四节小组活动方案的设计是对前期收集的精神障碍患者与家属间出现沟通障碍表现与成因进行总结，并针对性为服务对象提供有效的信息。因此，服务对象均表示参与小组活动后其理论知识有很大的收获：

“我以前从来没有从理论的角度思考过我们家的问题，就是随心所欲地表达，在这次小组课里都会将我们家出现的现象用理论去解释，还挺有意思的。”（服务对象 5）

“这些理论确实挺有用的，我有时候在家也会不断思考这些问题并且进行实践。”（服务对象 4）

#### 6.2.1.2 沟通认知的改变

改善精神障碍患者及其家属对沟通的不合理认知是小组干预过程中非常重要的环节，也是提升精神障碍患者家庭沟通与问题解决能力的关键。在小组工作中服务对象与家庭成员间对沟通障碍认知的变化，他们开始认识到自己家庭中产生的问题是常见的，这是因为自身非理性观念引起的：

“我今天在小组里听到大家的分享，我才知道好像每个精神障碍患者家庭都会出现相似的状况，怎么会提醒了一遍两遍还是听不进去呢，我真的每次都火大，还不能冲他发火，影响他的情绪。”（服务对象 1）



中国知网 https://www.cnki.net

“我一直觉得我很难和我的女儿沟通，尤其是她犯病的时候，她呢本来性格就比较内向，后来又得了精神分裂症就更加不说话了。但是看到她在小组里和这些同样患了精神分裂的朋友时不时交流互动，我对在家和她沟通也越来越有信心了。”（服务对象 4）

其次是改变了对沟通方式的不合理认知，服务对象开始意识到自己之前与家人间的沟通方式存在问题，并也正在有意识的改正。

“我就是一个性格特别直的人，有啥就会说啥。在上课的时候你们把这几种沟通方式一放出来，我就在想我是不是用这样的方式和子女沟通，结果还全都中了。”（服务对象 1）

#### 6.2.1.3 沟通主动性增强

通过在小组中不断实践与学习，服务对象间相互交流与分享，服务对象们说话变得更加主动，也解决了部分家庭中面对的问题。

“我和女儿一起来参加活动的嘛，在每次小组活动中我真的看到了她的变化，你看她现在也开始主动与同龄人沟通，虽然还是有点少，还是看到了他的进步。她在家也是，以前问她问题都说不知道，现在她也在慢慢主动表达自己的观点。”（服务对象 4）

“其实我的主动性也增加了，你发现没有？以前我都没有征求女儿的意见，我上次听了你说的，也要让她表达，我也开始主动去问女儿的感受和情况了。”（服务对象 1）

#### 6.2.1.4 沟通态度的转变

经过 8 周的学习，在小组活动与家庭日常生活中不断练习，服务对象与家人的沟通态度变得更加积极。

“我这个人耐心就不怎么好，每次看到我女儿做得不好的地方我都会去说



中国知网 https://www.cnki.net

她。上了这个课之后，我觉得还是女儿心情好最重要，我呢要求也没那么多了，现在看到她能够帮我干一些家务活，我就觉得很高兴了。”（服务对象 1）

“我之前和你说的我爸要求我吃南瓜的事情嘛，现在我觉得也不是那么重要了。我开始想到其实他只是觉得吃南瓜对我很好，所以希望我天天都能吃一点。所以，我就主动去和我爸说了这件事情，我说我知道他是在关心我，但是考虑到他有糖尿病，以后还是少吃一点。结果我爸居然后来就真的没有那么频繁给我做南瓜了。我觉得我现在又愿意和他沟通了。”（服务对象 3）

### 6.2.2 定量结果评估

开展精神障碍患者与家属间的小组工作具有一定的特殊性，在小组开展过程中，有 3 名服务对象中途退组。其中，一名精神障碍患者由于精神状况不稳定被家属送入医院治疗；一名精神障碍患者家属由于突发心脏病提前离组；一名精神障碍患者家属在小组中期调整时间后，因时间冲突无法继续参加后测。因此，本次小组实际参与后测的服务对象仅有 4 位，下表 14 仅展示 4 位服务对象的《亲子沟通量表》前后测数据对比。

表 14 《亲子沟通量表》前后测数据对比

| | | 表达能力 | | | 倾听能力 | | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 主动性 | 清晰性 | 策略性 | 开放性 | 敏感性 | 合计 |
| 1 | 前测 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 2.50 | 2.75 | 15.25 |
| | 后测 | 3.25 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 2.50 | 14.25 |
| 2 | 前测 | 2.00 | 2.75 | 2.75 | 2.00 | 2.25 | 11.25 |
| | 后测 | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 13.25 |
| 3 | 前测 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 3.50 | 16.00 |
| | 后测 | 3.75 | 4.00 | 3.00 | 3.25 | 2.75 | 16.75 |
| 4 | 前测 | 2.00 | 2.50 | 1.75 | 3.25 | 2.75 | 12.25 |
| | 后测 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 14.75 |

通过《亲子沟通量表》前后测数据对比可以发现，有三位服务对象《亲子



中国知网 https://www.cnki.net

沟通量表》前后测总分呈上升趋势，其中一位总分略有下降。这表示，提升精神障碍患者与家属间沟通能力的小组工作具有一定成效。

从亲子沟通能力各维度来看，表达主动性、表达清晰性两个维度后测均值均有所增加，笔者认为这是由于通过同质性的小组工作，服务对象开始愿意在组内主动分享过去经历与体验。同时，社会工作者在每节活动结束后都会为服务对象布置相应任务，因此服务对象在家庭内也愿意主动表达、主动分享，这在一定程度上也促进了精神障碍患者表达清晰性维度的提升。其次，服务对象的倾听开放性后测均值也有部分提升。笔者认为服务对象倾听开放性维度提升原因是他们在小组内了解了更多精神障碍患者家庭面临的更多问题，认识到沟通障碍不是个体事件，很多精神障碍患者家庭同样面临着相同的问题。因此，他们对家庭沟通中其他事件或矛盾的接纳程度逐渐增加，进而提升了服务对象的倾听开放性。

但是，从上表 14 中我们同样可以看到，《亲子沟通量表》中表达策略性和倾听敏感性维度后测均有两位服务对象得分有所下降。笔者认为下降原因是：一方面，在小组干预方案设计过程中，表达策略性和倾听敏感性两个维度涉及较少，且表达策略性和倾听敏感性应是一个长期训练的过程， 8 节小组工作仅让服务对象了解相关知识，在能力提升方面效果不明显；另一方面，实际调查过程中仅有 4 位服务对象参与《亲子沟通量表》后测，这也使得后测数据分析结果不准确。

### 6.2.3 参与式观察评估小组成效

#### 6.2.3.1 提升了精神障碍患者的自信

随着小组开展，内容不断深入，服务对象在小组内部也在悄然发生着变化。在第三节小组“优点轰炸”活动中，每位服务对象都需要写出自己的优点，以及其他服务对象的优点。起初可以明显观察到，每位服务对象都写不出来，在社会工作者的不断鼓励下，服务对象才勉强写出来几个词语。不过随着小组的不断推进，中后期服务对象开始发现其他服务对象的优点，在小组活动分享时，笔者也观察到服务对象间开始发自内心称赞其他服务对象，而这种现象在小组中年纪稍长的服务对象更为明显。笔者认为，这是服务对象沟通意识逐渐转变，并且不断内化的过程。



中国知网 https://www.cnki.net

#### 6.2.3.2 增加了精神障碍患者家庭的社会支持

随着小组工作的实施与推进，服务对象间有了更多交流的话题，他们不仅会分享与小组主题相关的内容，还会在在小组内分享自己其他生活事件。此外，在活动设计中，相关体验游戏也对服务对象之间的关系起到了促进作用，通过互动游戏也拉进了服务对象的距离。同时，本次小组也为服务对象营造了一个开放温馨的沟通氛围，增强了服务对象对小组的归属感。每次活动前，服务对象都会提前来到预定活动场地，坐下来彼此分享，了解对方一周内与家庭成员沟通情况。

服务对象组外的人际关系的促进主要体现在服务对象生活互动频率的增加。通过此次小组活动增加了有相同兴趣爱好的精神障碍患者或家属相互认识，他们在组外相约共同参与其他康复服务，这也增加了他们的社会支持网络。



中国知网 https://www.cnki.net

# 7 反思与建议

## 7.1 反思

### 7.1.1 小组活动内容丰富，但针对性有待加强

本次小组主要围绕着提高服务对象的倾听和表达技巧、沟通知识和沟通意识来展开的，其中还包括家庭冲突与问题解决能力、正向沟通与反馈等内容。小组内容总体来说比较丰富，也具有一定的针对性，但整体而言，本次小组方案的设计还不够深入，难以保证服务对象在短暂的时间内充分掌握小组内容。另外，由于小组中服务对象中既有精神障碍患者又有精神障碍患者家属，并且他们都是个人独立参加，并非以家庭的形式报名。因此，本次小组活动内容仅聚焦于双方普遍存在的问题，针对性还有待加强。

### 7.1.2 小组活动应聚焦于家庭系统

精神障碍患者是社会弱势群体，大部分公众缺乏对此类群体的认知与认同。本次研究受到服务对象家庭参与活动意识、服务对象身体状况等主客观方面因素的影响，因此在小组内容设计时并没有将家庭作为系统整体进行考量，仅从个体层面研究改善家庭沟通意识与能力的情况。尤其是本研究只有精神障碍患者或其中一名家属固定参与，难以推动家庭沟通系统提升，改善精神障碍患者与家属间沟通能力水平。因此，在以后的相关小组工作中，有必要以家庭为单位，从家庭系统出发设计小组工作。

### 7.1.3 整合社会工作服务方法，提高服务效果

精神障碍患者与家属间产生沟通障碍的原因是多方面的，它不仅会受到微观个体层面的影响，同样也会受到整个宏观环境的影响。但是，本研究仅从微观层面出发，运用小组工作的方法来提升精神障碍患者与家属间的沟通能力，这种服务方案不能完全回应服务对象的所有需求。因此，在提升精神障碍患者与家属间沟通能力的实务过程中，有必要整合社会工作服务方法，从多层面、多维度出发，为精神障碍患者及家属提供服务。由于笔者在实习过程中时间及精力有限，所以在方案设计过程中，笔者仅运用了小组工作的方法，开展了 8 次小组活动。虽然从小组工作的规模和成效评估的结果来看，本次小组在持续



中国知网 https://www.cnki.net

提供服务的短时间内还比较可行，效果也比较显著。但是总体来说， 服务对象相对较少，并且也没有对小组过程中表现特殊或有需要的服务对象进一步的个案跟进。在条件允许的情况下，提升精神障碍患者及家属沟通能力的干预研究还应充分整合个案工作、小组工作、社区工作等社会工作三大服务方法，开展长期服务，并定期跟进，不断调整工作方向与内容。

### 7.1.4 引入广义教育学思想，提升服务对象的反思能力

能力可以分为人与知识和技能之间的能力以及人与人之间的能力（张威，2018）。实际上，本文在提升精神障碍患者与家属间的沟通能力方面，仍停留在服务对象能够掌握沟通理论相关知识与技能层面。但是，由于每位服务对象都有不同的成长经历和价值观，他们在日常生活中即便掌握了沟通的知识，也可能会存在因面对不同场合或是不同的人用不上所学知识的情况。

其实，不论是精神障碍患者与家属的沟通能力，或是与其他人的沟通能力，归根结底就是与人沟通的能力。要想具备与人沟通的能力，事先要有能力与人建立关系，而这种关系体现在广义教育学领域被称为“教育关系纽带”（张威，2018）。教育关系纽带是教育者与受教育者之间的关系。如果教育者的为人处事的方式和态度被受教育者接受和认可，那么教育者和受教育者之间就形成了教育关系纽带（张威，2018）。此外，教育者能够与被教育者建立“教育关系纽带”又需要教育者具有反思能力。反思能力是一种诸多能力形成的综合能力，它要求人需具备强大的洞察力、感受力、系统思维能力、结构思维能力、行动能力以及与人建立关系的能力等。具备反思能力的人能够准确地洞悉事态的全局，感受人的内心，洞察到矛盾的薄弱环节，从而建立行动方向。

因此，提升精神障碍患者与家属沟通能力，如果仅从知识层面来增加精神障碍患者与服务对象的沟通理论知识，往往只能起到隔靴搔痒的效果。更重要的是，从广义教育学的思想思考，精神障碍患者与家属间出现沟通障碍可能不只是沟通层面的问题，而是双方是否具备反思能力。因此，要实现精神障碍患者与家属间沟通能力根本上提升，归根结底是要提升服务对象的反思能力，而反思能力的建设不能一蹴而就，它是长期而漫长的过程。



中国知网 https://www.cnki.net

### 7.1.5 提升社会工作者实务能力，保障服务对象参与度

在开展提升精神障碍患者与家属沟通能力的小组工作过程中，有 3 位服务对象中途退组，最后仅 4 位服务对象稳定参加。笔者将 3 位服务对象退组原因总结为以下两点：第一，服务对象自身身心状况具有特殊性。精神障碍患者随时可能因擅自减药、停止服药或外部环境刺激导致精神疾病复发，本次小组就有一位服务对象偷偷减少服药量导致状况不稳定被家属送入医院治疗；此外，由于精神障碍患者家属年龄均超过 60 岁，他们身体也患有各种慢性疾病。本次小组工作中，一位 83 岁服务对象因突发心脏病提前离组，以上情况均是在小组开展前社会工作者无法预料到的。第二，社会工作者实务经验不足。一方面，社会工作者在小组开展前组员招募与筛选过程中仅将服务对象沟通能力预估结果及服务对象参与小组意愿两者纳入考量，并未考虑到精神障碍患者与家属的身体情况。但如果社会工作者在小组开展前已有相关评估服务对象身心状况是否适宜参加小组工作，服务对象因身心状况而退组的现象可以在一定程度上避免；另一方面，社会工作者小组时间安排不恰当，因此有 1 位服务对象中途离组，这也体现了社会工作者实务经验的不足。

因此，为了保障服务对象参与度，笔者认为社会工作者在开展精神障碍患者与家属的小组工作时，还需要全方位评估精神障碍患者与家属的身体状况。对于那些因身心原因暂不适宜参加小组的服务对象，社会工作者可以采用个案工作的方法，为精神障碍患者或家属提供针对性服务；同时，对于那些在小组开展过程中因身心状况不得不离组的服务对象，社会工作者也应进行持续跟进，了解离组服务对象的身心及沟通能力情况，及时提供必要的社会服务。最后，社会工作者还应不断丰富实务经验，并持续接受培训与督导，在不断总结和反思中提高社会工作者的实务能力。

## 7.2 提升精神障碍患者与家属沟通能力的建议

提升精神障碍患者与家属间的沟通能力对于精神障碍患者康复具有积极作用。本研究在提升精神障碍患者与家属间沟通能力方面取得一定成效，但是长期而言，8 节小组工作难以达到持续性效果。因此，笔者认为，提升精神障碍患者与家属沟通能力需要多方发力、多措并举。



中国知网 https://www.cnki.net

### 7.2.1 家庭层面

家庭是精神障碍患者康复与社会融入的首要环境，因此从家庭系统层面出发，对于改善精神障碍患者与家属间沟通能力至关重要。

一方面，家庭需要建立良好的家庭氛围，为精神障碍患者提供信任、包容与无条件的爱的氛围，让精神障碍患者在家庭中敢沟通、能沟通、会沟通。精神障碍患者家属需要将精神障碍患者作为正常人来看待，不能因为精神上的疾病疏远精神障碍患者或放弃与精神障碍患者沟通，这会忽视了精神障碍患者的潜力，影响精神障碍患者康复效果；

另一方面，精神障碍患者家庭需要加大同其他精神疾病家庭交流频率。在小组工作过程中笔者发现，精神障碍患者与家属间产生沟通障碍的原因具有一定的相似性。透过同类家庭间的分享与交流，精神障碍患者家庭不仅可以学习其他家庭面对沟通障碍时的解决办法，还可以使家庭间相互讨论，增加精神障碍患者家庭的社会支持网络。

### 7.2.2 专业社会工作机构层面

专业社会工作机构是精神障碍患者社区康复的重要力量，他们在提升精神障碍患者与家属间沟通能力的过程中也能够发挥重要作用。

首先，专业社会工作机构需要提升自身服务能力，做到服务有针对性，为精神障碍患者提供有深度、有广度的服务。与此同时，机构内社会工作者也应当学习与接受沟通能力等理论与实务相关培训，让实务工作者了解并且会熟练运用实务方法提升精神障碍患者与家属间沟通能力水平；

其次，专业社会工作机构需要与其他医疗机构合作，在精神障碍患者出院前对精神障碍患者家庭情况如家庭经济情况、家庭氛围、家庭沟通情况进行紫铜评估。必要时社会工作者还可以提前进入医院开展预防性的工作，实现精神障碍患者居家康复治疗的过渡作用；

最后，专业社会工作服务机构应长期开展沟通能力相关服务。社会工作者可采用整合个案工作、小组工作、社区工作的方法针对性开展长期服务，定期检测成效。同时，专业社会工作机构应针对精神障碍患者家属开展压力舒缓的相关服务，避免精神障碍患者家属因照护压力过大产生负面情绪，影响与精神障碍患者的沟通。



中国知网 https://www.cnki.net

### 7.2.3 政府层面

一个家庭内如果沟通顺畅，那么在面临应对突发事件、危机与逆境时不易被击垮。政府可以从宏观层面为精神障碍患者营造良好的外部环境，如开放包容的社会氛围、政策支持等，间接提升精神障碍患者与家属的沟通能力。

首先，基层政府需要关注到精神障碍患者群体，从宏观政策层面给予精神障碍患者家庭充分的支持，加大精神障碍患者宣传力度，让社会公众了解精神障碍患者，减少对精神障碍患者的公众污名，在全社会为精神障碍患者及家庭营造开放包容的氛围；

其次，政府还需要加大精神障碍患者家庭补贴或治疗保障，让精神障碍患者家庭在面对逆境时，仍有各种宏观保护措施，不用为基本生活费、医疗费发愁；

最后，政府还应当加大购买专业服务于精神障碍患者社会工作机构服务力度，让精神障碍患者专业服务机构在具备人财物力保障时，提供更加深入、更加精准的社会工作服务。



中国知网 https://www.cnki.net

# 8 研究结论

本研究在亲子沟通理论、家庭抗逆力理论和家庭系统理论的指导下，运用社会工作干预研究的研究范式，并通过使用《家庭抗逆量表》和《亲子沟通量表》总结分析精神障碍患者与家属间沟通障碍现状及成因，并针对性设计了 8 节小组工作，以提升精神障碍患者与家属的沟通能力。

本研究验证了小组工作提升精神障碍患者与家属的沟通能力具有一定效果。首先，小组工作能够增加服务对象的沟通知识，他们开始从理论层面分析与家庭成员间产生沟通障碍的原因，也开始愿意将小组内学习了解到的理论知识运用于实际生活中；同时，服务对象不合理的沟通认知有一定程度改变，他们认识到沟通障碍是一个普遍议题，也开始意识到自己之前与家人的沟通方式存在问题，并也正在有意识地改正中；最后，小组工作也能够提升服务对象的沟通主动性及开放性，转变服务对象的沟通态度，提高精神障碍患者的自信，增加精神障碍患者家庭的社会支持。透过丰富的小组活动，服务对象间有更多互动机会，这也改善了家庭氛围。

但是，本研究也存在一定不足，针对不足部分笔者也进行了以下反思。首先，小组活动内容虽然丰富，但难以保证服务对象在短时间内充分掌握小组内容；其次，个人层面的服务难以推动整个家庭沟通系统的变化，小组活动应聚焦于家庭系统；第三，小组工作的服务方案不能完全回应服务对象的所有需求，因此需要运用整合社会工作服务方法，从多层面、多维度出发，为精神障碍患者及家属提供服务；第四，仅从知识层面来增加精神障碍患者与服务对象的沟通理论知识，往往只能起到隔靴搔痒的效果，更重要的是引入广义教育学思想，提升服务对象的反思能力；第五，提升社会工作者的实务能力，全方位评估精神障碍患者与家属的身体状况，提供更精准的服务，保障服务对象参与度。

最后，本文也从家庭、专业社会工作机构和政府层面，提出了提升精神障碍患者及家属沟通能力的建议。首先，家庭需要建立良好的家庭氛围并加大同其他精神疾病家庭交流频率；其次，专业社会工作机构应当接受培训，开展长期、稳定、持续的服务，定期评估成效；最后，政府需要加大对精神障碍患者家庭的基本生活补贴与医疗保障，同时加大社会服务购买力度，为精神障碍患者提供更精准的社会服务。



中国知网 https://www.cnki.net

# 参考文献

著作类：

[1]安秋玲（译）,马克·W·弗雷泽,杰克·M·里奇曼,等.干预研究：如何开发社会项目[M].上海教育出版社:上海,2018:63.

[2]风笑天.社会研究方法[M].中国人民大学出版社:北京,2018:177-180.

[3]高万红.多维度下的抑郁青少年的亲子关系研究[M].光明日报出版社:北京,2013:1-242.

[4]高万红.精神障碍康复：社会工作的本土实践[M].社会科学出版社:北京,2019:1-311.

[5]顾东辉.社会工作概论[M].复旦大学出版社:上海,2008:1-381.

[6]黄曼聪,陈威胜,陈芝萍:《精神健康职能治疗理论与实务》,五南图书出版股份有限公司,2009:1-257.

[7]刘梦,张和清.小组工作[M].高等教育出版社:北京，2003:209.

[8]阮胤华（译）,马歇尔·卢森堡.非暴力沟通[M].华夏出版社:浙江,2009:53.

[9]叶锦成.自我分裂与自我整合[M].社会科学文献出版社:北京,2013:1-301.

[10]朱眉华（译）. Froma Walsh．家庭抗逆力［M］.华东理工大学出版社：上海，2013.

[11]朱东武,朱眉华主编.家庭社会工作［M］.高等教育出版社:北京,011.

期刊论文类：

[1]池丽萍.亲子沟通的三层次模型:理论、工具及在小学生中的应用[J].心理发展与教育,2011,27(02):140-150.

[2]池丽萍.大学新生亲子沟通质量与“信任圈”的关系[J].心理与行为研究,2013,11(05):648-653.

[3]池丽萍,俞国良.不同学业成绩儿童的亲子沟通比较[J].心理科学,2012,35(05):1091-1095.

[4]陈丽,刘艳.流动儿童亲子沟通特点及其与心理健康的关系[J].中国特殊教



中国知网 https://www.cnki.net

育,2012(01):58-63.

[5]陈雪莹.有情绪?无问题——正向教养小组助力亲子沟通[J].中国社会工作,2017(33):24-25.

[6]方晓义,戴丽琼,房超,邓林园.亲子沟通问题与青少年社会适应的关系[J].心理发展与教育,2006(03):47-52.

[7]高万红,穆静.会所模式在精神障碍者社区康复中的应用研究——以昆明 T 会所为个案[J].中国社会工作研究,2015(01):41-67.

[8]顾东辉,童红梅,朱燕敏,孔繁雪.远离毒品:青少年禁毒的社会工作干预[J].社会,2004(12):42-45.

[9]宫焕凤,宋元成.精神障碍患者的社会交往技能培训[J].中国医学创新,2014,11(26):113-117.

[10]花菊香.跃迁与整合:论精神病患社会支持的专业性与操作性[J].江苏社会科学,2010(05):33-37.

[11]黄丹琪,程明明,徐韦云,等.社区康复精神障碍者就业现状与个案干预——以上海市 H 区阳光公园为例[J].都市社会工作研究,2018,1(5):66-84.

[12]何雪松,余潇.社区精神分裂症康复患者的社会功能小组干预[J].华东理工大学学报(社会科学版),2015,30(06):13-20.

[13]何丽英,姜杨,陈鸟玲,丁颖,樊素群.基于团队训练改善精神分裂症患者社会角色的研究[J].医院管理论坛,2018,35(05):46-48.

[14]焦佳凌.社会工作在精神障碍救治救助和社区康复中的支持作用[J].社会福利,2019(05):46-47.

[15]亢明,李坚,谢健.社会心理干预的家庭治疗与精神分裂症的康复[J].中国神经精神疾病杂志,1992(05):258-260+317.

[16]雷志洁,陈小红.搭乘训练对康复期慢性精神分裂症患者自我效能感的影响[J].四川精神卫生,2016,29(04):336-337.

[17]刘芳.西方社区精神康复理论——复原理论:背景、概念、过程与原则[J].法制博览,2019(15):41-42.

[18]乔若杨，李响.精神卫生领域“去机构化”运动的实践路径与反思[J].残疾人发展理论研究,2018,2(01):29-34.

[19]孙晓冬,郭申阳,陈奇.定量方法在干预研究中的运用：以“让我们做朋友-陕西”为例



中国知网 https://www.cnki.net

[J].社会建设,2020,7(06):16-29.

[20]童敏.社会工作的机遇与挑战:精神病人社区康复过程中的社会服务介入[J].北京科技大学学报(社会科学版),2006(03):1-5.

[21]童敏.当今西方精神健康服务发展的新趋向——复原模式的演变和争论[J].北京科技大学学报(社会科学版),2008(03):1-6.

[22]文军，刘昕.近八年以来中国社会工作研究的回顾与反思[J].华东理工大学学报(社会科学版), 2015,30(06):1-12+39.

[23]吴锐微.孩子,把你的手给我——社区亲子沟通小组[J].中国社会工作,2017(15):35-36.

[25]汪光珩.我国青少年亲子沟通研究综述[J].上海青年管理干部学院学报,2006(04):33-36.

[26]薛莉莉.实然与应然相结合的精神医疗社会工作服务模式——以上海市精神卫生中心社会工作部为例[J].中国社会工作,2017(27):25-29.

[27]徐云,李幸,余小敏.成都地区亲子沟通现状调查[J].中国妇幼保健,2013,28(27):4509-4510.

[28]严芳,姚丰菊,李拴荣,张艳萍,王素红,王晶花,张朝辉.同伴支持在社区精神分裂症患者中的应用[J].中华护理杂志,2019,54(10):1545-1550.

[29]俞银华,王丽娟,沈国珍,徐东娥,姜杨.团队生活技能训练在社区精神障碍患者康复中的应用[J].医院管理论坛,2014,31(10):60-62.

[30]赵鹤宾,夏勉,曹奔,江光荣.接触干预在减少精神障碍公众污名中的应用[J].心理科学进展，2019，27(05):843-857.

[31]赵环.从“关闭病院”到“社区康复”——美国精神卫生领域“去机构化运动”反思及启示[J].社会福利,2009(07):57-58.

[32]邹义壮,Jacques Dubuis,Denis Leguray,Eric Malapert,Jean Dalery.法国精神卫生的分区化服务模式[J].临床精神医学杂志,2000(04):247-248.

[33]张威.家庭社会化功能的弱化现象以及现代社会工作的战略性应对[J].社会工作,2018(06):3-22+109.

[34]张干群.城市高年级小学生亲子沟通状况调查[J].青少年研究(山东省团校学报), 2013(04):40-43.



中国知网 https://www.cnki.net

[35]周波,张智.初中生亲子沟通特点及其与 SCL-90 的关系[J].中国心理卫生杂志,2007(01):46-49.

[36]周皓.家庭社会经济地位、教育期望、亲子交流与儿童发展[J].青年研究,2013(03):11-26+94.

[37]朱敏青,李颖茵.儿童绘本在幼儿亲子沟通小组中的运用——以佛山湖景社区亲子沟通小组为例[J].青少年研究与实践,2020,35(01):106-112.

[38] Anthony W. A. ,Cohen M. ,Farkas M. ,Cohen B. F.(1988) ,Clinical care update :The chronically mentally ill. *Community Mental Health Journa*l, 1988,24(3),219-228.

[39]Bailey, V. (2001). Cognitive–behavioral therapies for children and adolescents. *Advances in Psychiatric Treatment*, 7(3), 224-232.

[40]Hofmann, S.G., Asnaani, A., Vonk, I.J.J. et al.(2012). The Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy: A Review of Meta-analyses. *Cognitive Therapy Research*. 36, 427–440 .

[41]Keri Black, Marie Lobo(2018). A conceptual review of family resilience factors. *Journal of Family Nursing*, 14,33-55.

[42]Marshall M，Gray A，Lockwood A，and Green R.，(1988).Case management for people with severe mental disorders. *Cochrane Database of Systematic Review*, 2,225.

[43]Olson, D. H. ,McCubbin H.I, Barnes, H., Larsen A., Muxen M.&Wilson M.（1982）.Family Inventories. University of Minnesota，St.Paul.

[44]Olson, D. H.,&DeFrain, J. (2003). Marriages and families: Intimacy diversity and strengths. *NY: McGraw-Hill Companies*, Inc.

[45]Raffaelli, Marcela & Bogenschneider, Karen & Flood, Mary. (1998). Parent-Teen Communication About Sexual Topics. *Journal of family issues*. 19. 315-337.

学位论文类：

[1]陈慧萍. 个案工作方法介入抑郁症患者家庭的亲子沟通研究[D].中南民族大学,2019.

[2]陈建伟. 农村留守儿童家庭亲子沟通能力提升的个案研究[D].西南大学,2020.

[3]胡毅. 绘画治疗介入留守儿童亲子沟通问题的个案研究[D].江西财经大学,2018.

[4]李玉丽. 父母肢体残疾的青少年创伤后成长与家庭弹性的关系及机制[D].山东大学,2016.



中国知网 https://www.cnki.net

[5]李晓静. 城市流动儿童家庭亲子沟通小组工作的实践研究[D].华东师范大学,2014.

[6]刘晓利. 照顾共同体：精神病患者社区康复的必然转向[D].南京理工大学,2019.

[7]刘晓雨. 互助型成长小组介入轻度精神障碍残疾人自我认知研究[D].华中科技大学,2019.

[8]马依莎. 小组工作介入农村康复期精神障碍患者自我效能感的提升研究[D].西南大学,2020.

[9]申佩佩. 个案工作介入外来务工离异家庭亲子沟通问题的研究[D].湘潭大学,2020.

[10]彭大丽. 小组工作提升“大孩”亲子沟通能力研究[D].西华大学,2020.

[11]徐原. 精神障碍者综合性职业康复模式研究[D].云南大学,2014.

[12]张平. 小组工作介入城市隔代教养家庭中亲子沟通问题研究[D].大连海事大学,2020.

[13]赵加琴. 提升流动儿童家长亲子沟通技巧的社会工作实践研究[D].云南大学,2019.

[14]訾美玲. 园艺治疗在亲子成长小组中的运用[D].郑州大学,2018.



中国知网 https://www.cnki.net

# 附录

附录 1：基本情况调查表

评估问卷

尊敬的先生/女士：

您好！社区康复一直以来都是我们机构服务的宗旨与目标。为更好服务精神障碍康复者家庭，近期我们想要开展一个以家庭为单位的小组活动。因此需要了解您家庭现状，以指导小组的方向，确定小组的内容。所有内容仅供评估与研究使用，我们不会泄露您的任何信息。感谢您的理解与合作！

请您仔细阅读以下每　条并判断在何种程度上该条　符合您对于家庭的描述，您可以将您任何家庭成员都考虑在内，请在相应的　格内打“✓”。

第一部分 基本信息

姓名_____　　年龄_____

1. 您是　☐康复者　☐康复者家属

康复者患病时长

☐0-5 年　☐5-10 年　☐10-20 年　☐20-30 年　☐大于 30 年

2. 与周围人相比，您认为自己的经济状况处于什么位置？

☐最下层　☐中下层　☐中间层　☐中上层　☐最上层

3. 您的婚姻状况是：

☐未婚　☐已婚　☐同居　☐离婚　☐丧偶

4. 您家中现有_____人一起生活

☐1　☐2　☐3　☐4　☐5　☐6 人及以上



中国知网　https://www.cnki.net

第二部分 家庭情况调查 *

选择答案的原则是：

非常同意：这　项　常准确的描述了您的家庭；

同意：这　项　致上描述了您的家庭；

不同意：这　项不太符合您的家庭；

非常不同意：这　项完全不符合您的家庭。

| | 非常同意 | 同意 | 不同意 | 非常不同意 |
|---|---|---|---|---|
| 1.我们家能够灵活应对突发事件。 | | | | |
| 2.我们能够澄清因言行不当对彼此造成的伤害，并获得对方的谅解。 | | | | |
| 3.我们家能够适应外界带给我们的各种挑战。 | | | | |
| 4.我们家愿意接受新的做事方式。 | | | | |
| 5.家庭成员之间能够彼此相互理解。 | | | | |
| 6.困难时，我们会向邻居们寻求帮助和支援。 | | | | |
| 7.我们相信能够处理我们遇到的问题。 | | | | |
| 8.我们彼此不理解时，能要求对方做出解释说明。 | | | | |
| 9.我们家能够真诚和坦率的对待彼此。 | | | | |
| 10.在家里我们可以发脾气，且能得到家人的理解。 | | | | |
| 11.家庭发生矛盾时，家人间能够相互谦让取得妥协。 | | | | |
| 30.我们尝试各种新方法解决问题。 | | | | |
| 31.我们能够理解其他家庭成员传达的信息。 | | | | |
| 32.我们在沟通时都尽量避免家庭成员受到情感或躯体伤害。 | | | | |

* 出于对版权的保护，本量表仅呈现部分条目。



中国知网 https://www.cnki.net

## 附录 2：亲子沟通量表

亲子沟通量表

| | 非常不符合 | 比较不符合 | 比较符合 | 非常符合 |
|---|---|---|---|---|
| 1.在家庭讨论中，主动积极发言。 | | | | |
| 2.在家庭谈话中，尊重对方想法。 | | | | |
| 3.能准确阐明自己的观点。 | | | | |
| 4.在提及某些敏感的话题时很有技巧。 | | | | |
| 5.在别人说话时，能耐心倾听。 | | | | |
| 6.对讨论的话题，乐于提出自己的看法。 | | | | |
| 7.允许对方表达不同想法和感受。 | | | | |
| 8.能清楚表达自己的意图。 | | | | |
| 9.在说服别人时，很有方法。 | | | | |
| 10.能毫不费力地察觉到对方的感受和意图。 | | | | |
| 11.自觉提出并讨论所面临的问题。 | | | | |
| 12.能容忍他人发表不同意见。 | | | | |
| 13.说话有条理。 | | | | |
| 14.对谈话中的尴尬和矛盾机智的化解。 | | | | |
| 15.善于体察对方的心情。 | | | | |
| 16.在谈话中表现的积极主动。 | | | | |
| 17.能够听取他人的不同建议和意见。 | | | | |
| 18.表达的意见明确好懂。 | | | | |
| 19.说话时注意技巧和方法。 | | | | |
| 20.能迅速领会别人话语的含义。 | | | | |



中国知网 https://www.cnki.net

附录 3：小组访谈提纲

一、小组开展前访谈提纲

**照顾者访谈提纲**

（一）基本情况

姓名、教育程度、婚姻状况、

1. 家庭的经济状况？是怎么维持生计的?

（二）患病经历

1.疾病类型、患病时长、

2. 从什么时候开始照顾的?

3. 描述一下从早到晚，一天的 24 小时都做了什么?

4. 每天需要做哪些事情?照顾过程中有什么困难?怎么解决?家人帮忙吗?

(1)刚开始照顾的时候有什么困难?

(2)现在照顾最主要的困难?

（三）与家庭成员情况

5. 家里人平时有什么娱乐活动?有没有共同的爱好?有没有一起出去过？一起出去的时候都是干什么去?

6. 家庭中的沟通方式是什么样的?平时会不会争吵?

7. 家里人有冲突吗?有的话怎么解决?

8. 家人平时会不会给予病人鼓励和支持?怎么做的?给自己哪些鼓励支持?

9. 家人之间会分享情绪，彼此交流吗?

10. 发病后家里会不会有人相互埋怨?

11. 有没有得到外界的帮助?比如社区?残联?邻居?亲戚?教会?工作单位?

12. 平时与外部有什么交往?

(1)平时都去谁家串门?

(2)过年过节的时候都去谁家串门?谁来家里串门?

(3)微信上都跟谁说话?

(4)犯病的时候谁会来帮忙?

13. 记忆中有没有什么印象深刻的事是别人帮助您的?

14. 得病之后对家庭产生了什么影响？

15. 家人为康复者做出什么改变或努力？



中国知网 https://www.cnki.net

16. 您是怎样看待这个病的?您认为能为他（她）做什么？
    （1）刚开始的时候怎么想，后来怎么想?
    （2）最开始确诊的时候是怎么想的，后来犯病怎么想的？
    （3）现在处于康复期又是怎么想的？
17. 你认为你家跟别人家有没有什么区别?
18. 发现这个病之后家庭是怎么适应的?
19. 您是否有宗教信仰?对家庭面对疾病有什么作用?
20. 家里人会不会讨论以后怎么办?(敢不敢想以后?不敢的话，为什么？)

**精神障碍患者访谈提纲**

1. 家庭中的沟没有通方式是什么样的?平时会不会争吵?
2. 家人平时会不会对你鼓励和支持?怎么做的?给自己哪些鼓励支持?
3. 遇到开心的事或伤心的事，你会和家人分享吗？
4. 你希望家人怎么和你相处？
5. 记忆中有没有什么印象深刻的事是别人帮助你的?
6. 你对于精神障碍康复期的看法是怎样的？
7. 你是怎样看待这个病的?
    （1）刚开始的时候怎么想，后来怎么想?
    （2）最开始确诊的时候是怎么想的，后来犯病怎么想的？
    （3）现在处于康复期又是怎么想的？
8. 会不会想以后生活怎么过?(敢不敢想以后?不敢的话，为什么?

**二、小组结束后访谈提纲**

1. 今天小组活动就结束了，请您谈谈您刚开始报名参加这个小组的时候对它的期待是怎样的呢?
2. 回顾 8 节小组内容，您觉得，您刚提到的那些期待有没有实现呢?哪些实现了呢?除了这些之外，还有其它的收获吗?
3. 通过参加 6 节亲子小组，您和您的家庭成员的关系有发生什么改变吗?态度



中国知网 https://www.cnki.net

有发生改变吗?能具体谈谈是哪些小组内容帮助您产生了这些改变吗?

4. 您喜欢这种大家一起讨论的的形式吗?为什么?
5. 您对于小组开展的频率、每节小组的时长和整个小组服务的周期长度有什么改进的建议吗?



中国知网 https://www.cnki.net